厦门市人民政府公报

厦门市人民政府　　2022年第12期(总第516期)　　2022年12月15日出版

目　录

【市府文件】

厦门市人民政府令第185号 …… (2)

厦门市人民政府关于印发《厦门市职工医疗保险实施细则》和《厦门市城乡居民医疗保险实施细则》的通知 …… (3)

厦门市人民政府关于印发加快推进政务服务标准化规范化便利化实施方案的通知 …… (20)

厦门市人民政府关于印发厦门市医疗救助办法的通知 … (26)

厦门市人民政府关于印发贯彻落实国务院计量发展规划(2021—2035年)实施方案的通知 …… (30)

厦门市人民政府关于同意一处市级文物保护单位更名的批复 …… (36)

【市府办文件】

厦门市人民政府办公厅关于印发进一步稳经济稳市场主体若干措施的通知 …… (37)

厦门市人民政府办公厅关于印发行政许可事项清单的通知 … (38)

厦门市人民政府办公厅关于成立厦门市人民政府行政复议咨询委员会的通知 …… (39)

【目录索引】

2022年11月市政府文件目录索引 …… (40)

编辑委员会名单

主　任:李辉跃

副主任:黄　杰

委　员:曾沿沿　毛　凯　欧阳恩亮　曹荣宝　李勇岩　蔡飞元　洪耀荣　李木林

主　编:曾沿沿

编辑出版:厦门市人民政府办公厅

编辑部地址:厦门市湖滨北路61号

责任编辑:江鹭燕

电　话:2891392

邮　编:361018

印　刷:厦门市直属机关印刷厂

电　话:2896387

★市府文件★

厦门市人民政府令

第185号

《厦门市捐资兴学奖励办法》已经2022年10月19日市人民政府第25次常务会议通过，现予公布，自2023年1月1日起施行。

市长 黄文辉

2022年10月22日

厦门市捐资兴学奖励办法

第一条 为了促进捐资兴学，发展厦门市教育事业，弘扬尊师重教优良传统，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称捐资兴学，是指境内外自然人、法人和非法人组织自愿无偿为厦门市教育事业捐赠各类财产的行为。

第三条 捐资兴学应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和他人的合法权益。

第四条 市、区人民政府鼓励境内外自然人、法人和非法人组织捐资兴学，推动厦门市教育事业的发展。

市、区教育主管部门负责捐资兴学奖励的具体工作。

第五条 教育主管部门应当根据本市教育事业发展规划，合理引导捐资兴学，有效发挥捐赠财产的社会效益。

第六条 自然人捐赠财产单次或者两年累计人民币5万元以上，法人和非法人组织捐赠财产单次或者两年累计人民币10万元以上的，由区人民政府通报表扬，并颁发表扬证书。

第七条 自然人捐赠财产两年累计人民币20万元以上，法人和非法人组织捐赠财产两年累计人民币50万元以上的，由市人民政府通报表扬，并颁发表扬证书。

第八条 市、区人民政府可以采取下列方式对捐赠人予以通报表扬：

(一)设立尊师重教碑，并在碑上刻载或者以信息化技术记载捐赠人姓名、名称以及捐赠财产数额等捐赠信息；

(二)向社会公布通报表扬决定，并在报纸、电视、网络等媒体对捐赠人的捐赠行为予以宣传；

(三)其他易于公众知晓的方式。

第九条 拟通报表扬的捐赠人人选，由受赠单位向教育主管部门提出，并按照教育主管部门的要求提供相应材料。

拟通报表扬的捐赠人名单，由教育主管部门审核后报同级人民政府批准。

教育主管部门可以委托教育基金会等组织办理相关人选的收集、汇总、初审等具体工作。

第十条 捐赠人捐资兴办的学校、捐建的校舍或者教室以及其他各类建筑物、捐赠的教育教学设施设备或者生活设施设备以捐赠人姓名、名称命名的，应当按照法律、法规和国家有关规定办理。

捐赠人对捐资兴办的学校、捐建的校舍或者教室以及其他各类建筑物等工程项目可以留名纪念；捐赠人单独捐赠的工程项目或者主要由捐

厦门市人民政府关于印发《厦门市职工医疗保险实施细则》和《厦门市城乡居民医疗保险实施细则》的通知

厦府规〔2022〕12号

各区人民政府,市直各委、办、局,各开发区管委会,各有关单位:

《厦门市职工医疗保险实施细则》和《厦门市城乡居民医疗保险实施细则》已经第25次市政府常务会议研究通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。

厦门市人民政府

2022年11月4日

厦门市职工医疗保险实施细则

第一章 总 则

第一条 为规范职工医疗保障关系,维护职工医疗保障合法权益,推动医疗保障事业健康发展,根据国家和福建省深化医疗保障制度改革精神,结合本市实际,制定本实施细则。

第二条 本市基本医疗保险坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针,遵循保障水平与经济社会发展水平相适应、权利与义务相对应、公

赠人出资兴建的工程项目,可以由捐赠人提出工程项目名称,并依法办理相关审批手续。

捐赠人捐资设立的教育基金、教育项目,可以按照捐赠人的意愿确定名称。法律、法规另有规定的,从其规定。

第十一条 受赠单位接受捐赠后,应当向捐赠人出具合法、有效的收据。

鼓励受赠单位向捐赠人颁发捐赠证书、徽标等。

受赠单位可以聘请捐赠人担任荣誉职务。

第十二条 对促成捐资兴学做出突出贡献的人员,受赠单位可以给予表扬和奖励。

第十三条 通报表扬或者以其他方式公开表扬捐赠人的,应当事先征得捐赠人的同意。

第十四条 捐赠人捐赠财产用于教育事业,依照法律、法规和国家有关规定享受税收优惠。

第十五条 对捐资兴学做出突出贡献的港澳台同胞、华侨、外国人和非本市户籍的国内人士,可以按照《厦门市荣誉市民称号授予办法》等规定,授予“厦门市荣誉市民”称号。

第十六条 通过培训师资力量、提供实习岗位等方式为厦门市教育事业发展做出突出贡献的,经教育主管部门审核并报同级人民政府批准后,可以参照本办法第六、七条的有关规定予以表扬。

第十七条 本办法自2023年1月1日起施行。1995年6月8日厦门市人民政府令第12号公布,根据 2015年12月30日厦门市人民政府令第161号公布的《厦门市人民政府关于废止和修改部分市政府规章的决定》修正的《厦门市捐资兴学奖励办法》同时废止。

平与效率相结合的原则。基本医疗保险包括职工基本医疗保险(以下简称“职工医保”)和城乡居民基本医疗保险(以下简称“居民医保”)。

建立健全以基本医疗保险为主体,大病保险为延伸,医疗救助为托底,补充医疗保险、商业健康保险等相互衔接、共同发展的多层次医疗保障制度体系。

第三条 本实施细则适用于本市职工基本医疗保险、职工大病保险和生育保险的参保缴费、待遇支付及其监督管理。

第四条 本市行政区域内的国家机关、企业、事业单位、社会组织、有雇工的个体工商户等用人单位(以下统称“用人单位”)及其职工应当参加职工医保。

法定劳动年龄内的本市户籍人员、本市有效居住证持有人(含港澳台人员),属于无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工医保的非全日制从业人员、新就业形态劳动者以及其他灵活就业人员的(以下统称“灵活就业人员”),可以个人身份参加职工医保。

本实施细则所称的职工,包括在职职工(含灵活就业人员)和退休人员;其中退休人员是指享受职工医保退休待遇的人员。

第五条 市医疗保障行政部门是本市职工医保的主管部门。医疗保障经办机构具体负责职工医保经办服务工作。

税务部门负责职工医保(含生育保险)的征收工作。

财政、人力资源和社会保障、卫生健康、发展改革、市场监督管理、审计、民政、公安、机构编制管理、退役军人、银保监等部门,在各自职责范围内负责有关的医疗保障工作。

第二章 职工基本医疗保险

第一节 基本医疗保险费征收

第六条 职工基本医疗保险费由用人单位和职工分别按其缴费基数的7.5%和2%按月共同缴纳。

灵活就业人员基本医疗保险费的缴费率为9.5%,由个人缴纳。

第七条 职工基本医疗保险费用人单位缴费基数为职工工资总额,工资总额按其在职职工缴费基数之和确定。

职工个人缴费基数为本人上年度月平均工资。职工本人上年度月平均工资低于上年度全省全口径城镇单位就业人员平均工资(以下简称“省平均工资”)60%的,以上年度省平均工资的60%作为缴费基数;超过上年度省平均工资300%以上的,以上年度省平均工资的300%作为缴费基数。

新参加工作或从异地调入本市工作的人员,按本人月工资推算得出缴费基数。其他个人上年度月平均工资无法计算的,以上年度省平均工资为缴费基数。

灵活就业人员在上年度省平均工资的60%–300%范围内选择缴费基数。

第八条 工资总额的构成以统计部门规定为准,用人单位应当每年按规定申报上一年度职工工资总额。

省平均工资以统计部门公布的为准,缴费基数上下限统一于每年的7月1日调整。本实施细则所称上年度省平均工资,是指上半年按上上年度省平均工资计算;下半年按上年度省平均工资计算。

第九条 用人单位应当自成立之日起30日内向税务部门申请办理职工医保参保登记。

用人单位的职工医保参保登记事项发生变更或用人单位依法终止的,应当自变更或终止之日起30日内,到税务部门办理变更或注销职工医保参保登记。

第十条 用人单位应当自用工之日起30日内为其职工申请办理职工医保参保登记,并按规定缴纳基本医疗保险费;逾期办理的,应当补缴自录用之日起的基本医疗保险费。用人单位出现参保人员辞退、辞职、退休、死亡等情形的,应当在30日内向税务部门办理变更手续。

灵活就业人员自愿参加职工医保的,应当向税务部门申请办理职工医保参保登记。

第十一条 用人单位和灵活就业人员应当自行申报、按时足额缴纳基本医疗保险费,非因不可抗力等法定事由不得缓缴、减免。

职工应当缴纳的基本医疗保险费由用人单位代扣代缴,用人单位应当按月将缴纳基本医疗保险费的明细情况告知本人。

第十二条 用人单位未按规定申报应当缴纳的基本医疗保险费数额的,或未按时足额缴纳基本医疗保险费的,依照《中华人民共和国社会保险法》有关规定执行。

第十三条 税务部门应当依法征收基本医疗保险费,并及时向医疗保障经办机构通报征收情况。

市场监督管理、民政、机构编制管理部门应当及时向税务部门和医疗保障经办机构通报用人单位的成立、终止等情况;卫生健康、民政、公安机关应当及时向税务部门和医疗保障经办机构通报个人的出生、死亡等情况;公安机关应当及时向税务部门和医疗保障经办机构通报户口登记、迁移、注销,以及居住证签发、签注等情况。

第十四条 用人单位有权查询单位缴费记录,参保人员有权查询个人权益记录,并要求医疗保障经办机构提供医疗保障咨询等相关服务。个人有权监督本单位为其缴费情况。

第十五条 参保人员不得重复参保、重复享受待遇。发现重复参保的,按下列原则予以清理:

(一)重复参加职工医保的,原则上保留就业地参保关系;

(二) 跨制度重复参保且连续参加职工医保一年以上(含一年)的,原则上保留职工医保参保关系。

重复参保缴纳的职工基本医疗保险费不予退回,城乡居民基本医疗保险费在待遇享受期开始前可申请退费。

本实施细则所称重复参保,是指同一参保人员重复参加同一基本医疗保险制度或重复参加不同基本医疗保险制度,具体表现为同一时间段内同一参保人员有两条及以上参保缴费状态正常的参保信息记录。

第二节 统筹基金和个人账户

第十六条 职工基本医疗保险基金由统筹基金和个人账户组成,其计息办法按照国家有关规定执行。

第十七条 用人单位缴纳的基本医疗保险费全部计入统筹基金,按规定收取的滞纳金以及其他收入计入统筹基金。

第十八条 在职职工个人缴纳的基本医疗保险费按月划入个人账户,划入标准为本人参保缴费基数的2%。

退休人员个人账户由统筹基金按月按定额划入,划入标准为每人每月110元。

第十九条 个人账户的本金和利息归个人所有,可以跨年度结转使用。

参保人员死亡的, 终止其基本医疗保险关系,在结清相关医疗费用后,其个人账户实际结余资金可依法继承;依法没有继承人的,个人账户实际结余资金划归统筹基金。

参保人员出国定居丧失中国国籍或出境定居注销户籍的,可申请一次性领取个人账户实际结余资金。

参保人员跨统筹区流动并按规定办理基本医疗保险关系转移接续的,其个人账户实际结余资金可随同转移。

第二十条 参保人员可自愿设立家庭共济账户,用于本人及其父母、子女、配偶等直系亲属(以下统称“家庭成员”)之间健康综合保障。其中,家庭成员应当属于福建省基本医疗保险的参保人员。家庭成员之间只能设立一个家庭共济账户。

家庭共济账户资金为个人账户实际结余资金超过福建省规定金额的部分,经参保职工本人授权后从个人账户划出。个人账户资金先于家庭共济账户资金使用,涉及多个个人账户的,应当指定家庭共济账户使用个人账户资金的先后顺序。

家庭共济账户的结转、计息等按照个人账户有关规定执行。办理继承、转移的,其家庭共济账户属于本人的实际结余资金归并到个人账户。

第二十一条 个人账户和家庭共济账户资金可用于支付参保人员本人及其家庭成员的下列费用:

(一) 在定点医疗机构就医发生的由个人负担的医疗费用;

(二)在定点零售药店购买药品、医疗器械、医用耗材发生的由个人负担的费用;

(三)缴纳参加居民医保的保费;

(四)其他符合国家和省规定的项目。

不予支付的范围按照国家、省规定执行。

第三节 基本医疗保险待遇

第二十二条 基本医疗保险基金支付范围按照国家、省有关规定执行,包括基本医疗保险(含生育保险)药品、医用耗材、医疗服务项目等医保目录,以及医保支付标准、个人先行自付比例和最高支付限价等。

参保人员在定点医药机构就医、购药发生的符合基金支付范围的费用,由基本医疗保险基金按照规定的起付标准、支付比例和最高支付限额予以支付。

第二十三条 参保人员在定点零售药店购买药品、医疗器械、医用耗材发生的费用,可由个人账户或家庭共济账户资金支付,其中购买处方药品需持定点医疗机构开具的处方。

实施"双通道"管理机制,将符合条件的定点零售药店提供的用药保障服务纳入门诊保障范围,执行省统一的"双通道"药品范围。参保人员按规定购买"双通道"处方流转药品发生的费用,实行与开具处方定点医疗机构就医相同的医保支付政策。

第二十四条 一个医保年度内参保人员发生的符合基金支付范围的门诊医疗费用,按下列规定支付:

(一) 门诊起付标准以内的医疗费用由个人负担,可由个人账户或家庭共济账户资金支付:在职职工门诊起付标准为累计1200元,退休人员为累计800元。

(二) 超过门诊起付标准的医疗费用由统筹基金按比例支付,其余由个人负担:

1.1万元以下的部分,在职职工在三级、二级、一级及未定级定点医疗机构的支付比例分别为75%、85%、90%;退休人员在三级、二级、一级及未定级定点医疗机构的支付比例分别为85%、90%、95%;

2. 超过1万元的部分,在职职工在三级、二级、一级及未定级定点医疗机构的支付比例分别为90%、93%、95%;退休人员在三级、二级、一级及未定级定点医疗机构的支付比例分别为95%、97%、98%。

第二十五条 参保人员在基层公立定点医疗机构门诊就医,使用已纳入国家医保药品目录的国家基本药物发生的医疗费用,不设起付标准,由统筹基金按门诊规定比例支付(相关费用不计入门诊起付标准累计)。

第二十六条 一个医保年度内参保人员发生的符合基金支付范围的住院医疗费用,按下列规定支付:

(一) 住院起付标准以内的医疗费用由个人负担,可由个人账户或家庭共济账户资金支付:在职职工首次住院的,在三级、二级、一级定点医疗机构的起付标准分别为1000元、600元、200元;二次及二次以上住院的,在三级、二级、一级定点医疗机构的起付标准分别为500元、300元、100元。退休人员按前述标准减半计算。

(二) 超过住院起付标准的医疗费用由统筹基金按比例支付,其余由个人负担:在职职工在三级、二级、一级定点医疗机构的支付比例分别为90%、93%、95%;退休人员在三级、二级、一级定点医疗机构的支付比例分别为95%、97%、98%。

第二十七条 长期卧床不起、行动不便的参保人员符合建床条件的,可申请设立家庭病床,发生的符合基金支付范围的家庭病床医疗费用,实行住院支付政策。

设立家庭病床期间,参保人员在其他定点医疗机构另行发生的医疗费用(急诊和抢救除外),基本医疗保险基金不予支付。

第二十八条 定点医疗机构提供"互联网+"医疗服务,与线下医疗服务实行同等的医保支付政策。参保人员在本市"互联网+"医疗服务定点医疗机构复诊并开具处方发生的诊察费和药品费,按规定纳入医保支付范围。提供药品配送服务的费用不纳入医保支付范围。

第二十九条 参保人员发生的符合基金支付范围的医疗费用,在一个医保年度内基本医疗

保险统筹基金累计的最高支付限额为10万元。

第三十条 参保人员享受统筹基金支付待遇的标准,根据其医疗费用发生时连续参加基本医疗保险的时间确定:

(一)连续参保时间不满12个月的,按统筹基金正常待遇的50%支付;

(二)连续参保时间满12个月不满24个月的,按统筹基金正常待遇的75%支付;

(三)连续参保时间满24个月的,按统筹基金正常待遇的100%支付。

退休人员、医疗救助对象统筹基金支付待遇不受连续参保时间限制。

第三十一条 参保人员可与基层定点医疗卫生机构签订家庭医生签约服务协议,签约服务费由基本公共卫生服务经费、医保统筹基金和签约个人共同分担。个人负担部分可由个人账户或家庭共济账户资金支付,统筹基金负担部分由医疗保障经办机构与基层定点医疗卫生机构按规定结算。

第四节 转移接续和缴费年限认定

第三十二条 参保人员跨统筹地区流动,按规定办理基本医疗保险关系转移接续;生育保险关系随职工基本医疗保险关系一并转移接续。已享受职工医保退休待遇的,不再转移基本医疗保险关系。

办理转移接续手续后,其在异地的个人账户资金可转入本市, 与本市个人账户资金合并计算;职工医保缴费年限累计计算,但重复缴费的年限不得累加计算。

参加居民医保以及非按职工医保标准缴费的年限,不作为职工医保缴费年限。

第三十三条 参保人员在各地实施职工医保制度前,符合国家、省规定的连续工龄或工作年限以及缴纳基本养老保险费的年限,视同职工医保缴费年限。

第三十四条 具备申报本市职工医保退休待遇资格的人员包括:

(一)本市户籍人员;

(二) 在达到法定退休年龄时已实际缴纳本市职工基本医疗保险费满10年的非本市户籍人员(含港澳台人员、外国人);

(三)在达到法定退休年龄时,按国家、省规定参加福建省基本养老保险行业统筹或福建省本级机关事业单位养老保险,按照属地原则参加本市职工医保的省、部属驻厦用人单位参保人员;

(四)本市机关、事业单位编制人员及备案员额人员;

(五)本市认定的高层次人才及其配偶。

第三十五条 具备申报本市职工医保退休待遇资格的人员,达到法定退休年龄时,应当同时符合下列两个条件,方可享受本市职工医保退休待遇:

(一) 实际缴纳本市职工基本医疗保险费的年限满10年;

(二) 缴纳职工基本医疗保险费的累计年限(含实际缴费和视同缴费年限)男满25年、女满20年。

第三十六条 参保人员在申报职工医保退休待遇时,本市实际缴费年限或累计缴费年限不足的,应当一次性补足。补缴标准以办理补缴时上年度省平均工资的60%为缴费基数,按用人单位和职工个人的缴费比例之和一次性补足至规定的缴费年限;一次性补缴的基本医疗保险费全部进入统筹基金,不划入个人账户。按规定一次性补足缴费年限后,从补缴到账次月起确认享受职工医保退休待遇。

第三十七条 参保人员应当在达到法定退休年龄当月及时申报并确认职工医保退休待遇。未及时申报或未确认期间发生的医疗费用不享受医疗保障待遇;待确认后的次月起,享受职工医保退休待遇。

第三十八条 符合国家规定在本市或在省、部属驻厦用人单位办理养老保险提前退休,且退休时为本市职工医保的参保人员,按规定递减计算职工医保退休缴费年限标准,但递减后的累计缴费年限标准不得低于15年。

第三十九条 成建制转移单位的退休人员随在职职工一并转移基本医疗保险关系, 无需缴费;其转入时的在职职工不受本市实际缴费年限

10年限制。

第四十条 达到法定退休年龄的人员不得以在职职工身份继续参加本市职工医保,符合条件的可选择参加居民医保。

第四十一条 达到法定退休年龄的非本市户籍参保人员,不具备申报本市职工医保退休待遇资格的或不按规定一次性补缴不足缴费年限的,经本人申请,可按规定办理基本医疗保险关系转移接续;也可选择终止本市基本医疗保险关系,申请一次性领取个人账户实际结余资金。

第三章 职工大病保险

第四十二条 建立职工大病保险制度,对参保职工发生的符合规定的高额医疗费用给予进一步保障。

参加职工基本医疗保险的人员,同时参加职工大病保险,参保人员在享受基本医疗保险待遇的基础上享受大病保险待遇。

第四十三条 医疗保障经办机构作为投保人,为本市职工医保的参保人员集体向商业保险机构投保,按照大病保险合同约定统一向商业保险机构支付大病保险保费。

第四十四条 大病保险保费由职工基本医疗保险统筹基金和个人账户共同缴纳, 合理分担。职工个人负担部分由医疗保障经办机构每月从个人账户中代扣代缴。

第四十五条 一个医保年度内参保人员在定点医疗机构就医、在定点零售药店购买“双通道”药品,发生的符合基本医疗保险规定且应由个人自付的医疗费用纳入大病保险保障范围,按下列规定支付:

(一)大病保险起付标准为个人自付费用1万元,可由个人账户或家庭共济账户资金支付。

(二) 超过起付标准的个人自付费用由大病保险按比例支付,其余由个人负担:

1.个人自付费用在1万元至10万元(含)的部分,支付比例为75%;

2.个人自付费用在10万元至20万元(含)的部分,支付比例为85%;

3.个人自付费用超过20万元的部分,支付比例为95%。

(三) 一个医保年度内大病保险最高支付限额为110万元。

第四十六条 参保人员发生的下列符合规定的医疗费用,纳入个人自付费用计算范围:

(一)基本医疗保险门诊、住院起付标准医疗费用;

(二)基本医疗保险起付标准以上、统筹基金最高支付限额以下由个人按比例负担的医疗费用;

(三) 基本医疗保险统筹基金最高支付限额以上的医疗费用;

(四)医保目录乙类范围的药品、医用耗材、医疗服务项目按比例先由个人支付部分,以及药品和医用耗材医保支付标准以上最高销售限价以下的部分。

第四十七条 参保人员享受大病保险待遇的标准,根据其医疗费用发生时连续参加基本医疗保险的时间确定:

(一)连续参保时间不满12个月的,按正常待遇的50%支付;

(二)连续参保时间满12个月不满24个月的,按正常待遇的75%支付;

(三)连续参保时间满24个月的,按正常待遇的100%支付。

退休人员、医疗救助对象大病保险待遇不受连续参保时间限制。

第四十八条 大病保险待遇享受起止时间与基本医疗保险一致。中断缴费期间以及连续参保时间不足导致职工基本医疗保险统筹基金不予支付的医疗费用,大病保险也不予支付,且不计入个人自付费用计算范围。

第四十九条 大病保险遵循收支平衡、保本微利的原则,合理控制商业保险机构盈利率。医疗保障经办机构根据法律法规和国家有关规定选定承保职工大病保险的商业保险机构,签署保险合同,明确双方责任、权利和义务。

第五十条 商业保险机构应当加强大病保险服务队伍配置,提升专业服务水平,配合医疗保障部门加强对医疗服务和医疗费用的监管,发现违法违规行为应及时报告医疗保障部门,医疗

保障部门按规定予以查处。

第四章 生育保险

第五十一条 生育保险与职工基本医疗保险合并实施,统一缴费基数,参加职工基本医疗保险的用人单位在职职工同步参加生育保险。

第五十二条 用人单位应按规定参加生育保险,为本单位在职职工及时办理参保登记并按月足额缴纳生育保险费,职工个人不缴费。用人单位生育保险缴费率为0.7%。

机关、财政核拨或核补的事业单位生育保险缴费率为0.35%,其职工按原渠道领取工资,不享受生育津贴。

灵活就业人员不参加生育保险,不享受生育津贴。

第五十三条 生育保险待遇包括生育医疗费用和生育津贴,由职工基本医疗保险基金(含生育保险)支付。生育保险与其它社会保险不重复享受待遇。

第五十四条 生育医疗费用按照职工医保待遇规定支付结算。

第五十五条 职工在分娩、妊娠终止、实施计划生育手术前连续缴费满12个月(含当月)的,按规定享受生育津贴;当月正常参保缴费但连续缴费不满12个月的,生育津贴按正常待遇的50%支付。

第五十六条 生育津贴按职工所在用人单位上年度月平均工资,以每月30天进行折算,按日计发,时间标准如下:

(一)顺产128天;难产(含剖宫产)的增加15天;生育多胞胎的,每多生育一个婴儿,增加15天。

(二)怀孕3个月以内流产(含异位妊娠)的15天;怀孕3个月及以上流产的42天;怀孕7个月及以上流产的98天。

孕期妊娠月以28天即4周为1个月计算。

(三)实施计划生育手术:放置宫内节育器的7天;摘取宫内节育器的3天;输卵管结扎的30天;输精管结扎的15天;输卵管复通术的30天;输精管复通术的15天。

生育或流产时合并计划生育手术的,生育津贴天数按就高原则领取、不叠加享受。

(四)上年度无生育保险征缴记录的当年新成立用人单位,其生育津贴按上年度省平均工资计发。

第五十七条 参保男职工本人享受实施计划生育手术的生育保险待遇。

参保男职工未就业配偶生育的,享受生育医疗费用待遇。其未就业配偶没有参加基本医疗保险的,由职工基本医疗保险基金参照本市居民医保待遇标准支付生育医疗费用。

第五十八条 职工应当自生育之日起24个月内或实施计划生育手术之日起12个月内携带相应材料到医疗保障经办机构按规定申领生育津贴待遇。

第五章 就医结算管理

第五十九条 参保人员在定点医药机构就医、购药和结算医药费用,享受医疗保障待遇,应当持本人医保电子凭证或社会保障卡等其他符合国家、省规定的医疗保障凭证,并遵守基本医疗保险有关规定。社会保障卡按规定统一由人力资源和社会保障部门制发和管理。

定点医药机构应当加强实名就医和购药管理,在提供医药服务时核验参保人员的医疗保障凭证。

任何组织和个人不得冒用、伪造、变造、出借、出租医疗保障凭证。

第六十条 参保人员就医、购药发生的医药费用通过医保信息系统即时直接结算。其中,应当由个人支付的部分,由参保人员支付给定点医药机构;应当由医疗保障基金支付的部分,由医疗保障经办机构与定点医药机构按规定结算。

第六十一条 参保人员因行动不便等特殊情况不能到定点医疗机构就医配药的,按规定办理登记手续后,可委托他人进行门诊代配药。除外伤外, 所配药品限于治疗经临床医师诊断明确、病情稳定、治疗方案确定的慢性病、精神病。受托人应当提供委托人医疗保障凭证以及本人有效身份证件。

第六十二条 参保人员在福建省内全省联网定点医药机构就医、购药直接结算医药费用，无需办理异地就医备案手续，医保支付范围和医保待遇执行本市医保规定。

第六十三条 符合条件的跨省异地长期居住人员和跨省临时外出就医人员按规定办理跨省异地就医备案手续，在备案地定点医疗机构发生的医疗费用按规定纳入医保支付范围。

参保人员备案后跨省异地就医发生的医疗费用，直接结算的，原则上执行就医地规定的医保支付范围及有关规定，医保待遇执行本市规定；因故无法直接结算的，回本市医疗保障经办机构按本市医保支付范围和医保待遇规定审核报销。

第六十四条 除急诊和抢救外，参保人员未按规定办理跨省异地就医备案手续，在省外定点医疗机构发生的符合基本医疗保险规定的医疗费用先由个人负担10%后再按本市规定享受待遇；在省外定点零售药店发生的医药费用不予报销。

第六十五条 每年1月1日至12月31日为一个基本医疗保险年度。参保人员在当年度内发生的医疗费用应当在下一个基本医疗保险年度开始后的3个月内(即3月31日前)结算完毕。参保人员死亡的，其亲属应当在3个月内结清医疗费用。除法定不可抗力因素外，逾期办理的，医疗保障经办机构不予结算医疗费用。

第六十六条 除国家、省另有规定外，下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围：

(一)在非定点医药机构发生的(急诊和抢救除外)；

(二)应当从工伤保险基金中支付的；

(三)应当由第三人负担的；

(四)应当由公共卫生负担的；

(五)在境外就医的；

(六)体育健身、养生保健消费、健康体检；

(七)国家、省规定的基本医疗保险基金不予支付的其他费用。

医疗费用依法应当由第三人负担，第三人不支付或无法确定第三人的，由基本医疗保险基金先行支付。基本医疗保险基金先行支付后，医疗保障经办机构有权向第三人追偿。

第六十七条 因重大公共疫情或受大规模自然灾害影响造成的医疗费用支出，按照国家、省、市有关规定执行。

第六章 待遇生效和中断

第六十八条 参加本市职工医保的人员，当月办理参保登记并次月缴费到账的，医疗保险关系从参保登记当月开始生效；参保登记次月缴费未到账的，医疗保险关系从实际缴费到账当月开始生效。

第六十九条 参保缴费时间应当保持连续，不得随意中断。未按规定及时按月足额缴纳基本医疗保险费的，认定为中断缴费，并按下列规定处理：

(一)从中断缴费次月起，暂停享受医疗保障待遇，个人账户和家庭共济账户资金可继续使用，中断期间发生的医疗费用不计入个人自付费用计算范围；

(二)中断缴费3个月(含)以内续保并补缴中断期间基本医疗保险费且次月缴费到账的，视为连续，中断月份计入连续参保时间，中断期间的待遇可按规定追溯享受；

(三)中断缴费超过3个月以上的，中断期间不享受医疗保障待遇。重新参保并次月缴费到账的，从参保当月起开始重新计算连续参保时间；重新参保次月缴费未到账的，从实际缴费到账当月起开始重新计算连续参保时间；

(四) 从其他统筹区转入本市并按规定办理基本医疗保险关系转移接续的参保人员，在转移接续前未中断缴费，或中断缴费3个月(含)以内续保并补缴中断期间基本医疗保险费且次月缴费到账的，在其他统筹区正常参保缴费时间可与本市参保缴费时间合并计算，中断月份计入连续参保时间。

第七十条 居民医保转换为职工医保的参保人员，其年度内发生的医疗费用累加计算，按转换后的参保险种享受基本医疗保险待遇。

在参保身份转换期间未中断缴费,或中断缴费3个月(含)以内续保并补缴中断期间基本医疗保险费且次月缴费到账的,视为连续;其参保身份转换前后的正常缴费时间合并计算,转换中断月份计入连续参保时间,中断期间的待遇可按规定追溯享受。

第七十一条 用人单位未按规定及时为职工办理参保登记或未按规定按月足额缴费,致使参保职工无法正常享受医疗保障待遇或生育保险待遇的,由用人单位按照本实施细则规定的待遇项目和标准支付给职工。

第七十二条 参保人员被判处拘役、有期徒刑、无期徒刑或死缓的,在服刑期间不缴纳基本医疗保险费,不享受医疗保障待遇。缓刑或监外执行期间、服刑期满释放或假释后,正常参保缴费,按规定享受医疗保障待遇。

第七章 基金监管和服务

第七十三条 职工基本医疗保险基金(含生育保险)纳入财政专户管理,专款专用,任何组织和个人不得侵占或挪用;执行国家统一的基金财务制度、会计制度和预决算制度。基金不足支付时,由财政部门统筹解决。

第七十四条 市医疗保障行政部门根据公众健康需求、管理服务需要、医保基金收支、区域卫生规划、医疗机构设置规划、参保人员用药需求等确定本市定点医药服务的资源配置。

医疗保障经办机构根据国家医疗机构和零售药店医疗保障定点管理办法及省、市评估细则,开展定点医药机构评估、确认工作。

第七十五条 医疗保障经办机构与医药机构协商谈判,签订服务协议,明确双方权利义务,规范医药服务行为,明确违约责任。

医疗保障经办机构应当及时向社会公布签订服务协议的定点医药机构名单。

第七十六条 医疗保障经办机构按规定及时与定点医药机构结算和拨付医疗保障基金,并预留部分金额作为质量保证金。医疗保障经办机构对定点医药机构开展绩效考核,建立动态管理机制。考核结果与年终清算、质量保证金退还、协议续签等挂钩。

第七十七条 定点医药机构应当为参保人员提供合理、必要的医药服务,执行符合规定的价格政策,提高服务质量,合理有效使用医疗保障基金。

在满足临床需求的前提下,定点医疗机构应当优先使用可由医疗保障基金支付的医药服务项目,控制患者自费比例;除急诊和抢救等特殊情况外,提供医疗保障基金支付范围以外的医药服务的,应当经参保人员或其近亲属、监护人同意。不得以医保支付政策为由拒收患者。

第七十八条 具备条件的医师按照长期处方管理规范,根据慢性病患者诊疗需要,一般可开具处方量在4周内的长期处方;根据慢性病特点,病情稳定的患者适当延长,最长不超过12周。

医疗机构及其医务人员按照医疗机构检查检验结果互认管理办法,在不影响疾病诊疗的前提下,对标有全国或本机构所在地区互认标识的检查检验结果予以互认,不得重复检查检验。

第七十九条 医疗保障基金使用监督管理实行政府监管、社会监督、行业自律和个人守信相结合。基金使用及监督管理按照《医疗保障基金使用监督管理条例》执行。

第八十条 医疗保障、卫生健康、市场监督管理、财政、审计、公安等部门应当分工协作、相互配合,建立沟通协调、案件移送等机制,对欺诈骗保行为依法予以查处。

(一) 医疗保障部门负责监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法行为;

(二) 卫生健康部门负责加强医疗机构和医疗服务行业监管,规范医疗机构及其医务人员医疗服务行为,监督管理中医医疗、预防、保健、康复以及临床用药等行为;

(三) 市场监督管理部门负责医疗卫生行业价格监督检查,执业药师管理,药品零售和使用环节质量监管,并规范相关行为;

(四)财政部门负责加强财政资金保障,监督医保基金支出情况;

（五）审计部门负责加强医保基金监管相关政策措施落实情况跟踪审计，督促相关部门履行监管职责，对在审计中发现的欺诈骗保问题及时移送相关部门查处；

（六）公安机关负责依法查处打击各类欺诈骗保等犯罪行为。

第八十一条 任何组织和个人有权对侵害医疗保障基金的违法违规行为进行举报、投诉。

医疗保障部门畅通举报投诉渠道，依法及时处理有关举报投诉，并对举报人的信息保密；对查证属实的举报，按照有关规定给予举报人奖励。

第八章 其他特别规定

第八十二条 根据国家、省有关规定和本市经济社会发展水平以及基本医疗保险基金的运行情况，市医疗保障行政部门可会同市财政部门对本细则中的参保缴费、个人账户、待遇保障、就医结算、监管和服务等提出调整方案，经市人民政府同意后实施。

第八十三条 建立医疗救助制度，对符合条件的救助对象经基本医疗保险、大病保险支付后，个人及其家庭难以承受的符合规定的自付医疗费用给予救助，具体办法另行制定。

第八十四条 用人单位可在参加基本医疗保险基础上，建立企业补充医疗保险，用于补助职工个人负担的医疗费用。

第八十五条 离休人员、老红军的医疗保障按照本市有关规定执行，军人及军队相关人员的医疗保障按照有关规定执行。

第八十六条 依法获得相关就业证件和外国人居留证件并在本市合法就业的外国人，与用人单位建立劳动关系的，可按规定参加职工医保。

持本市取得的外国人永久居留身份证件的人员，属于灵活就业的，可参照本市有效居住证持有人以个人身份参加职工医保。

第八十七条 本市认定的高层次人才及其配偶、子女可不受国籍、户籍限制，按规定参加职工医保。

第八十八条 1998年7月以前在本市办理养老保险退休的人员参加职工医保，不再缴纳基本医疗保险费，可享受职工医保退休待遇。1998年7月前人事行政关系或劳动关系隶属于本市的参保人员，自1998年7月起连续缴费至2003年12月的，医保退休不受本市实际缴费年限10年限制。

对原具有本市户籍并在达到法定退休年龄前参加过本市职工医保，但已到境外定居的人员，可视同本市户籍人员申报职工医保退休待遇。

第九章 附 则

第八十九条 本实施细则由市医疗保障局会同相关部门负责解释。

第九十条 本实施细则自2023年1月1日起实施，有效期5年。本市以往制定的有关职工医疗保险的规定与本实施细则不一致的，以本实施细则为准。《厦门市人民政府关于颁布<厦门市外来从业人员基本医疗保险暂行办法>的通知》（厦府〔2000〕综126号）、《厦门市人民政府办公厅关于同意调整外来从业人员由社会统筹医疗基金支付住院费用最高限额的批复》（厦府办〔2006〕187号）、《厦门市人民政府办公厅关于基层公立医疗机构严格执行国家基本药物制度的通知》（厦府办〔2010〕237号）、《厦门市人民政府关于印发大病医疗保险办法的通知》（厦府〔2018〕15号）、《厦门市人民政府关于公布职工基本医疗保险缴费基数和缴费费率的通知》（厦府规〔2021〕12号）同时废止。

厦门市城乡居民医疗保险实施细则

第一章 总 则

第一条 为规范城乡居民医疗保障关系,维护城乡居民医疗保障合法权益,推动医疗保障事业健康发展,根据国家和福建省深化医疗保障制度改革精神,结合本市实际,制定本实施细则。

第二条 本市基本医疗保险坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针,遵循保障水平与经济社会发展水平相适应、权利与义务相对应、公平与效率相结合的原则。基本医疗保险包括职工基本医疗保险(以下简称“职工医保”)和城乡居民基本医疗保险(以下简称“居民医保”)。

建立健全以基本医疗保险为主体,大病保险为延伸,医疗救助为托底,补充医疗保险、商业健康保险等相互衔接、共同发展的多层次医疗保障制度体系。

第三条 本实施细则适用于本市城乡居民基本医疗保险和城乡居民大病保险的参保缴费、待遇支付及其监督管理。

第四条 本市行政区域内,未参加职工医保或未按照规定享有其他医疗保障的下列城乡居民依法参加居民医保:

(一)本市户籍的成年居民

(二)未满18周岁的未成年人

1.本市户籍的未成年人;

2. 父亲或母亲持本市有效居住证且参加本市职工医保的非本市户籍未成年人。

(三) 本市经政府有关部门批准设立的各类全日制学校在校在园学生 (以下简称 “在校学生”)

各类全日制普通高等院校 (包括民办高校、独立学院、成人高等院校全日制普通班)、科研院所(以下统称“高校”)中接受普通高等学历教育的全日制本专科生、全日制研究生(以下统称“大学生”);中等职业学校(含中专、技校、职高)、特殊教育学校、中小学(含小学、初中、高中)中实行学籍管理的全日制学生;幼儿园、托儿所等幼托机构的在册儿童。

在校学生包括侨、港、澳、台籍学生,不包括以上高校中接受成人高等教育(含脱产、业余、函授形式学习)以及进修、网络、广播电视等学校的学生。

第五条 市医疗保障行政部门是本市居民医保的主管部门。医疗保障经办机构具体负责居民医保经办服务工作。

税务部门负责居民医保的征收工作。

教育部门负责组织落实全日制学校在校学生的参保工作。学校负责本校在校学生的参保登记工作。

村(居)委会负责本辖区内其他城乡居民的参保登记工作。

财政、人力资源和社会保障、卫生健康、发展改革、市场监督管理、审计、民政、公安、残联、农业农村、银保监等部门,在各自职责范围内负责有关的医疗保障工作。

第二章 城乡居民基本医疗保险

第一节 基本医疗保险费征收

第六条 城乡居民基本医疗保险费由财政和个人共同承担。建立与经济社会发展水平、财政负担能力和基本医疗消费需求相适应的动态调整筹资机制。具体筹资标准由市医疗保障、财政和税务部门共同研究,经市人民政府同意后公布执行。其中,财政补助资金由市、区两级财政分别承担50%。

第七条 符合资助参保政策的医疗救助对象及家庭经济困难大学生,参加居民医保所需个人缴费部分,由政府按规定给予资助。

第八条 城乡居民基本医疗保险基金只建立统筹基金,不设立个人账户。

第九条 城乡居民基本医疗保险费实行预缴制, 每年9月至12月为次年居民医保的集中参保缴费期。城乡居民应当在集中参保缴费期内按规

定办理参保登记手续,并按个人缴费标准一次性缴纳下一年度的基本医疗保险费。

超过集中参保缴费期,符合参保条件的城乡居民可以中途参保,中途参保人员按全年个人缴费标准缴纳基本医疗保险费。

第十条 在校学生原则上应在学籍地参加居民医保。新入学学生当年已参加异地居民医保的,在当年度内可继续享受原参保地医保待遇;选择参加本市居民医保并缴纳本年度基本医疗保险费的,本市居民医保待遇可追溯至参保登记月。

第十一条 在校学生通过所在学校办理居民医保参保申请,其他城乡居民向户籍所在地或居住地村(居)委会办理参保申请。学校或村(居)委会接到城乡居民申请、进行参保信息采集后,统一向税务部门办理参保登记手续。

已参加本市居民医保的参保人员,参保信息发生变化或下一医保年度中止参保的,应当及时办理变更或停保手续。参保信息未发生变化且须继续参保的参保人员,在新年度无需重新办理参保登记,按规定及时足额缴纳基本医疗保险费后,医疗保险关系自动延续。

第十二条 参保人员选择个人自缴的,可使用银行一卡通委托代扣、医保家庭共济账户代缴、线上缴费等方式进行缴费。通过学校或村(居)委会代缴的,学校或村(居)委会在规定期限内统一向税务部门申报缴纳。

第十三条 税务部门应当依法征收基本医疗保险费,并及时向医疗保障经办机构通报征收情况。

卫生健康、民政、公安机关应当及时向税务部门和医疗保障经办机构通报个人的出生、死亡等情况;公安机关应当及时向税务部门和医疗保障经办机构通报户口登记、迁移、注销,以及居住证签发、签注等情况。

第十四条 参保人员有权查询个人权益记录,并要求医疗保障经办机构提供医疗保障咨询等相关服务。

第十五条 参保人员不得重复参保、重复享受待遇。发现重复参保的,按下列原则予以清理:

(一)重复参加居民医保的,原则上保留常住地参保关系;

(二)学生重复参保的,原则上保留学籍地参保关系;

(三)跨制度重复参保且连续参加职工医保一年以上(含一年)的,原则上保留职工医保参保关系。

重复参保缴纳的职工基本医疗保险费不予退回,城乡居民基本医疗保险费在待遇享受期开始前可申请退费。

本实施细则所称重复参保,是指同一参保人员重复参加同一基本医疗保险制度或重复参加不同基本医疗保险制度,具体表现为同一时间段内同一参保人员有两条及以上参保缴费状态正常的参保信息记录。

第二节 基本医疗保险待遇

第十六条 基本医疗保险基金支付范围按照国家、省有关规定执行,包括基本医疗保险(含生育保险)药品、医用耗材、医疗服务项目等医保目录,以及医保支付标准、个人先行自付比例和最高支付限价等。

参保人员在定点医药机构就医、购药发生的符合基金支付范围的费用,由基本医疗保险基金按照规定的起付标准、支付比例和最高支付限额予以支付。

第十七条 参保人员可自愿设立家庭共济账户,用于本人及其父母、子女、配偶等直系亲属(以下统称"家庭成员")之间健康综合保障,按规定使用家庭共济账户资金。其中,家庭成员应当属于福建省基本医疗保险的参保人员。

第十八条 参保人员在定点零售药店购买药品、医疗器械、医用耗材发生的费用,可由家庭共济账户资金支付,其中购买处方药品需持定点医疗机构开具的处方。

实施"双通道"管理机制,将符合条件的定点零售药店提供的用药保障服务纳入门诊保障范围,执行省统一的"双通道"药品范围。参保人员按规定购买"双通道"处方流转药品发生的费用,实行与开具处方定点医疗机构就医相同的医保支付政策。

第十九条 一个医保年度内参保人员发生的符合基金支付范围的门诊医疗费用,按下列规定支付:

(一) 门诊起付标准以内的医疗费用由个人负担,可由家庭共济账户资金支付:成年居民门诊起付标准为累计500元,未成年人、在校学生不设门诊起付标准。

(二) 超过门诊起付标准的医疗费用由统筹基金按比例支付,其余由个人负担:

1.1万元以下的部分,在三级、二级、一级及未定级定点医疗机构的支付比例分别为45%、55%、65%;

2.超过1万元的部分,在三级、二级、一级及未定级定点医疗机构的支付比例分别为65%、75%、85%。

第二十条 参保人员在基层公立定点医疗机构门诊就医,使用已纳入国家医保药品目录的国家基本药物发生的医疗费用, 不设起付标准,由统筹基金按门诊规定比例支付(相关费用不计入门诊起付标准累计)。

第二十一条 一个医保年度内参保人员发生的符合基金支付范围的住院医疗费用,按下列规定支付:

(一) 住院起付标准以内的医疗费用由个人负担,可由家庭共济账户资金支付:成年居民首次住院的,在三级、二级、一级定点医疗机构的起付标准分别为1000元、600元、200元;二次及二次以上住院的,在三级、二级、一级定点医疗机构的起付标准分别为500元、300元、100元。未成年人、在校学生不设住院起付标准。

(二) 超过住院起付标准的医疗费用由统筹基金按比例支付, 其余由个人负担: 在三级、二级、一级定点医疗机构的支付比例分别为73%、80%、90%。

第二十二条 长期卧床不起、行动不便的参保人员符合建床条件的, 可申请设立家庭病床,发生的符合基金支付范围的家庭病床医疗费用,实行住院支付政策。

设立家庭病床期间,参保人员在其他定点医疗机构另行发生的医疗费用(急诊和抢救除外),基本医疗保险基金不予支付。

第二十三条 定点医疗机构提供“互联网+”医疗服务,与线下医疗服务实行同等的医保支付政策。参保人员在本市“互联网+”医疗服务定点医疗机构复诊并开具处方发生的诊察费和药品费,按规定纳入医保支付范围。提供药品配送服务的费用不纳入医保支付范围。

第二十四条 参保人员发生的符合基金支付范围的医疗费用,在一个医保年度内基本医疗保险统筹基金累计的最高支付限额为10万元。

第二十五条 参保人员享受统筹基金支付待遇的标准,根据其医疗费用发生时连续参加基本医疗保险的时间确定:

(一)连续参保时间不满12个月的,按统筹基金正常待遇的50%支付;

(二)连续参保时间满12个月不满24个月的,按统筹基金正常待遇的75%支付;

(三)连续参保时间满24个月的,按统筹基金正常待遇的100%支付。

未成年人、在校学生、医疗救助对象统筹基金支付待遇不受连续参保时间限制。

第二十六条 参保人员可与基层定点医疗卫生机构签订家庭医生签约服务协议,签约服务费由基本公共卫生服务经费、医保统筹基金和签约个人共同分担。个人负担部分可由家庭共济账户资金支付,统筹基金负担部分由医疗保障经办机构与基层定点医疗卫生机构按规定结算。

第三章 城乡居民大病保险

第二十七条 建立城乡居民大病保险制度,对参保居民发生的符合规定的高额医疗费用给予进一步保障。

参加城乡居民基本医疗保险的人员,同时参加城乡居民大病保险,参保人员在享受基本医疗保险待遇的基础上享受大病保险待遇。

第二十八条 医疗保障经办机构作为投保人,为本市居民医保的参保人员集体向商业保险机构投保,按照大病保险合同约定统一向商业保险机构支付大病保险保费。大病保险保费从城乡居民基本医疗保险统筹基金中划出。

第二十九条 一个医保年度内参保人员在定

点医疗机构就医、在定点零售药店购买“双通道”药品,发生的符合基本医疗保险规定且应由个人自付的医疗费用纳入大病保险保障范围,按下列规定支付:

(一)大病保险起付标准为个人自付费用3万元,可由家庭共济账户资金支付。

(二) 超过起付标准的个人自付费用由大病保险按比例支付,其余由个人负担:

1.个人自付费用在3万元至10万元(含)的部分,支付比例为60%;

2.个人自付费用在10万元至20万元(含)的部分,支付比例为70%;

3.个人自付费用超过20万元的部分,支付比例为80%。

(三) 一个医保年度内大病保险最高支付限额为50万元。

第三十条 特困供养人员、孤儿(含事实无人抚养儿童)、最低生活保障对象、返贫致贫人口等医疗救助对象, 大病保险起付标准降低50%,支付比例提高5个百分点, 并不设大病保险最高支付限额。

第三十一条 参保人员发生的下列符合规定的医疗费用,纳入个人自付费用计算范围:

(一)基本医疗保险门诊、住院起付标准医疗费用;

(二)基本医疗保险起付标准以上、统筹基金最高支付限额以下由个人按比例负担的医疗费用;

(三) 基本医疗保险统筹基金最高支付限额以上的医疗费用;

(四)医保目录乙类范围的药品、医用耗材、医疗服务项目按比例先由个人支付部分,以及药品和医用耗材医保支付标准以上最高销售限价以下的部分。

第三十二条 参保人员享受大病保险待遇的标准,根据其医疗费用发生时连续参加基本医疗保险的时间确定:

(一)连续参保时间不满12个月的,按正常待遇的50%支付;

(二)连续参保时间满12个月不满24个月的,按正常待遇的75%支付;

(三)连续参保时间满24个月的,按正常待遇的100%支付。

未成年人、在校学生、医疗救助对象大病保险待遇不受连续参保时间限制。

第三十三条 大病保险待遇享受起止时间与基本医疗保险一致。中断缴费期间以及连续参保时间不足导致城乡居民基本医疗保险统筹基金不予支付的医疗费用, 大病保险也不予支付,且不计入个人自付费用计算范围。

第三十四条 大病保险遵循收支平衡、保本微利的原则,合理控制商业保险机构盈利率。医疗保障经办机构根据法律法规和国家有关规定选定承保职工大病保险的商业保险机构,签署保险合同,明确双方责任、权利和义务。

第三十五条 商业保险机构应当加强大病保险服务队伍配置,提升专业服务水平,配合医疗保障部门加强对医疗服务和医疗费用的监管,发现违法违规行为应及时报告医疗保障部门,医疗保障部门按规定予以查处。

第四章 就医结算管理

第三十六条 参保人员在定点医药机构就医、购药和结算医药费用,享受医疗保障待遇,应当持本人医保电子凭证或社会保障卡等其他符合国家、省规定的医疗保障凭证,并遵守基本医疗保险有关规定。社会保障卡按规定统一由人力资源和社会保障部门制发和管理。

定点医药机构应当加强实名就医和购药管理,在提供医药服务时核验参保人员的医疗保障凭证。

任何组织和个人不得冒用、伪造、变造、出借、出租医疗保障凭证。

第三十七条 参保人员就医、购药发生的医药费用通过医保信息系统即时直接结算。其中,应当由个人支付的部分,由参保人员支付给定点医药机构; 应当由医疗保障基金支付的部分,由医疗保障经办机构与定点医药机构按规定结算。

第三十八条 参保人员因行动不便等特殊情况不能到定点医疗机构就医配药的,按规定办理登记手续后,可委托他人进行门诊代配药。除外

伤外，所配药品限于治疗经临床医师诊断明确、病情稳定、治疗方案确定的慢性病、精神病。受托人应当提供委托人医疗保障凭证以及本人有效身份证件。

第三十九条 参保人员在福建省内全省联网定点医药机构就医、购药直接结算医药费用，无需办理异地就医备案手续，医保支付范围和医保待遇执行本市医保规定。

第四十条 符合条件的跨省异地长期居住人员和跨省临时外出就医人员按规定办理跨省异地就医备案手续，在备案地定点医疗机构发生的医疗费用按规定纳入医保支付范围。

参保人员备案后跨省异地就医发生的医疗费用，直接结算的，原则上执行就医地规定的医保支付范围及有关规定，医保待遇执行本市规定；因故无法直接结算的，回本市医疗保障经办机构按本市医保支付范围和医保待遇规定审核报销。

第四十一条 学生放寒暑假、休学、参加学校规定的教育实践、课题研究、社会调查、短期在外学习和其他原因需跨省异地就医的，可由本人、本人亲属或学校按规定办理跨省异地就医备案手续，特殊情况下可由学校事后报备，发生的医疗费用按规定予以支付。

第四十二条 除急诊和抢救外，参保人员未按规定办理跨省异地就医备案手续，在省外定点医疗机构发生的符合基本医疗保险规定的医疗费用先由个人负担10%后再按本市规定享受待遇；在省外定点零售药店发生的医药费用不予报销。

第四十三条 每年1月1日至12月31日为一个基本医疗保险年度。参保人员在当年度内发生的医疗费用应当在下一个基本医疗保险年度开始后的3个月内(即3月31日前)结算完毕。10月至12月出生的新生儿、新入学学生在当年度内发生的医疗费用应当在下一个基本医疗保险年度开始后的6个月内(即6月30日前)结算完毕。参保人员死亡的，其亲属应当在3个月内结清医疗费用。除法定不可抗力因素外，逾期办理的，医疗保障经办机构不予结算医疗费用。

第四十四条 除国家、省另有规定外，下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围：

(一)在非定点医药机构发生的(急诊和抢救除外)；

(二)应当从工伤保险基金中支付的；

(三)应当由第三人负担的；

(四)应当由公共卫生负担的；

(五)在境外就医的；

(六)体育健身、养生保健消费、健康体检；

(七)国家、省规定的基本医疗保险基金不予支付的其他费用。

医疗费用依法应当由第三人负担，第三人不支付或无法确定第三人的，由基本医疗保险基金先行支付。基本医疗保险基金先行支付后，医疗保障经办机构有权向第三人追偿。

第四十五条 因重大公共疫情或受大规模自然灾害影响造成的医疗费用支出，按照国家、省、市有关规定执行。

第五章 待遇生效和中断

第四十六条 参加本市居民医保的人员，在集中参保缴费期内按规定缴纳下一年度的基本医疗保险费，医疗保险关系从次年1月1日起开始生效。

在当年度开始后参保缴费的城乡居民，当月办理参保登记并次月缴费到账的，医疗保险关系从参保登记当月开始生效；参保登记次月缴费未到账的，医疗保险关系从实际缴费到账当月开始生效。

第四十七条 新生儿出生后3个月内办理当年度参保登记并次月缴费到账的，医疗保险关系从出生之日起生效。出生3个月后办理当年度参保登记或未及时缴费的，按照第四十六规定执行。

第四十八条 参保缴费时间应当保持连续，不得随意中断。未按规定及时足额缴纳基本医疗保险费的，认定为中断缴费，并按下列规定处理：

(一)中断缴费一个年度及以上的，再次参保后连续参保时间重新计算，中断期间不享受医疗保障待遇；

(二)在当年度开始后3个月(含)以内参保并

补缴基本医疗保险费且次月缴费到账的,视为连续,中断月份计入连续参保时间,中断期间的待遇可按规定追溯享受;

(三)在当年度开始3个月后(即每年3月后)参保缴费,缴费之前不享受医疗保障待遇,缴费之前发生的医疗费用由个人负担,且不计入个人自付费用计算范围。参保次月缴费到账的,从参保当月起开始重新计算连续参保时间;参保次月缴费未到账的,从实际缴费到账当月起开始重新计算连续参保时间;

(四) 从其他统筹区转入本市并按规定办理基本医疗保险关系转移接续的参保人员,在转移接续前未中断缴费,或中断缴费3个月(含)以内续保并补缴基本医疗保险费且次月缴费到账的,在其他统筹区正常参保缴费时间可与本市参保缴费时间合并计算, 中断月份计入连续参保时间。

第四十九条 职工医保转换为居民医保的参保人员, 其年度内发生的医疗费用累加计算,按转换后的参保险种享受基本医疗保险待遇,职工个人账户实际结余资金可继续结转使用。

在参保身份转换期间未中断缴费,或中断缴费3个月(含)以内续保并补缴中断期间基本医疗保险费且次月缴费到账的,视为连续;其参保身份转换前后的正常缴费时间合并计算,转换中断月份计入连续参保时间,中断期间的待遇可按规定追溯享受。

第五十条 学生毕业、结业、转学、肄业,或按学籍管理规定被注销学籍,办理离校手续当年已缴纳本年度基本医疗保险费的,在当年度内可按原参保身份继续享受居民医保待遇。

第五十一条 参保人员被判处拘役、有期徒刑、无期徒刑或死缓的,在服刑期间不缴纳基本医疗保险费,不享受医疗保障待遇。缓刑或监外执行期间、服刑期满释放或假释后,正常参保缴费,按规定享受医疗保障待遇。

第六章 基金监管和服务

第五十二条 城乡居民基本医疗保险基金纳入财政专户管理,专款专用,任何组织和个人不得侵占或挪用; 执行国家统一的基金财务制度、会计制度和预决算制度。基金不足支付时,由财政部门统筹解决。

第五十三条 市医疗保障行政部门根据公众健康需求、管理服务需要、医保基金收支、区域卫生规划、医疗机构设置规划、参保人员用药需求等确定本市定点医药服务的资源配置。

医疗保障经办机构根据国家医疗机构和零售药店医疗保障定点管理办法以及省、市评估细则,开展定点医药机构评估、确认工作。

第五十四条 医疗保障经办机构与医药机构协商谈判,签订服务协议,明确双方权利义务,规范医药服务行为,明确违约责任。

医疗保障经办机构应当及时向社会公布签订服务协议的定点医药机构名单。

第五十五条 医疗保障经办机构按规定及时与定点医药机构结算和拨付医疗保障基金,并预留部分金额作为质量保证金。医疗保障经办机构对定点医药机构开展绩效考核,建立动态管理机制。考核结果与年终清算、质量保证金退还、协议续签等挂钩。

第五十六条 定点医药机构应当为参保人员提供合理、必要的医药服务,执行符合规定的价格政策,提高服务质量,合理有效使用医疗保障基金。

在满足临床需求的前提下,定点医疗机构应当优先使用可由医疗保障基金支付的医药服务项目,控制患者自费比例;除急诊和抢救等特殊情况外,提供医疗保障基金支付范围以外的医药服务的,应当经参保人员或其近亲属、监护人同意。不得以医保支付政策为由拒收患者。

第五十七条 具备条件的医师按照长期处方管理规范,根据慢性病患者诊疗需要,一般可开具处方量在4周内的长期处方;根据慢性病特点,病情稳定的患者适当延长,最长不超过12周。

医疗机构及其医务人员按照医疗机构检查检验结果互认管理办法,在不影响疾病诊疗的前提下,对标有全国或本机构所在地区互认标识的检查检验结果予以互认,不得重复检查检验。

第五十八条 医疗保障基金使用监督管理实行政府监管、社会监督、行业自律和个人守信相

结合。基金使用及监督管理按照《医疗保障基金使用监督管理条例》执行。

第五十九条 医疗保障、卫生健康、市场监督管理、财政、审计、公安等部门应当分工协作、相互配合,建立沟通协调、案件移送等机制,对欺诈骗保行为依法予以查处。

(一) 医疗保障部门负责监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法行为;

(二) 卫生健康部门负责加强医疗机构和医疗服务行业监管,规范医疗机构及其医务人员医疗服务行为,监督管理中医医疗、预防、保健、康复以及临床用药等行为;

(三) 市场监督管理部门负责医疗卫生行业价格监督检查,执业药师管理,药品零售和使用环节质量监管,并规范相关行为;

(四)财政部门负责加强财政资金保障,监督医保基金支出情况;

(五) 审计部门负责加强医保基金监管相关政策措施落实情况跟踪审计,督促相关部门履行监管职责, 对在审计中发现的欺诈骗保问题,及时移送相关部门查处;

(六) 公安机关负责依法查处打击各类欺诈骗保等犯罪行为。

第六十条 任何组织和个人有权对侵害医疗保障基金的违法违规行为进行举报、投诉。

医疗保障部门畅通举报投诉渠道,依法及时处理有关举报投诉, 并对举报人的信息保密;对查证属实的举报, 按照有关规定给予举报人奖励。

第七章 其他特别规定

第六十一条 根据国家、省有关规定和本市经济社会发展水平以及基本医疗保险基金的运行情况,市医疗保障行政部门可会同市财政部门对本细则中的参保缴费、待遇保障、就医结算、监管和服务等提出调整方案,经市人民政府同意后实施。

第六十二条 建立医疗救助制度, 对符合条件的救助对象经基本医疗保险、大病保险支付后,个人及其家庭难以承受的符合规定的自付医疗费用给予救助,具体办法另行制定。

第六十三条 持本市有效居住证的港、澳、台人员, 以及父亲或母亲持本市有效居住证的港、澳、台未成年人,可按规定参加居民医保。

第六十四条 在本市居住但未就业, 持本市取得的外国人永久居留身份证件的外国人,可参照本市户籍人员按规定参加居民医保。

第六十五条 本市认定的高层次人才及其配偶、子女可不受国籍、户籍限制,按规定参加居民医保。

第八章 附 则

第六十六条 本实施细则由市医疗保障局会同相关部门负责解释。

第六十七条 本实施细则自2023年1月1日起实施,有效期5年。本市以往制定的有关城乡居民医疗保险的规定与本实施细则不一致的,以本实施细则为准。《厦门市人民政府办公厅关于转发厦门市城镇居民医疗保险暂行办法的通知》(厦府办〔2006〕281号)、《厦门市人民政府办公厅关于转发厦门市未成年人医疗保险暂行办法的通知》(厦府办〔2006〕282号)、《厦门市人民政府办公厅关于切实做好农村居民医疗保险组织实施工作的通知》(厦府办〔2008〕24号)、《厦门市人民政府办公厅转发市劳动保障局财政局地税局关于厦门市大学生参加城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》(厦府办〔2009〕176号)、《厦门市人民政府办公厅转发市地税局、市财政局、市人力资源和社会保障局关于调整城乡居民医疗保险参保时间的通知》(厦府办〔2015〕45号)同时废止。

厦门市人民政府关于印发加快推进政务服务标准化规范化便利化实施方案的通知

厦府规〔2022〕13号

各区人民政府,市直各委、办、局,各开发区管委会,各有关单位:

《厦门市加快推进政务服务标准化规范化便利化实施方案》已经第28次市政府常务会议研究同意,现印发给你们,请认真组织实施。

厦门市人民政府

2022年11月21日

厦门市加快推进政务服务标准化规范化便利化实施方案

为加快推进政务服务标准化规范化便利化建设,持续优化全市政务服务软环境,根据《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》(国发〔2022〕5号,以下简称《指导意见》)和《福建省加快推进政务服务标准化规范化便利化的实施方案》(闽政〔2022〕24号),以下简称《实施方案》)要求,结合本市实际,制定本实施方案。

一、总体要求

(一)指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神和致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神,按照党中央、国务院和省委省政府的决策部署,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,坚持党的领导,坚持以人民为中心,坚持系统观念,坚持公平可及,聚焦提高效率、提升效能、提增效益,加快转变政府职能、深化“放管服”改革、持续优化营商环境,加强跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务协同管理和服务,全面提升全市一体化政务服务平台能力,进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化,在推进市域治理体系和治理能力现代化上取得更大突破,为全方位推进高质量发展超越提供有力支撑。

(二)总体目标。2022年底前,市、区、镇(街)、村(居)四级政务服务能力和水平显著提升;全市各级政务服务机构综合窗口实现全覆盖,一体化政务服务能力显著提升,“一网好办”服务能力显著增强,企业和群众经常办理的政务服务事项实现“跨省通办”“省内通办”“全市通办”。2025年底前,政务服务标准化、规范化、便利化水平大幅提升,全市高频政务服务事项按照全国统一标准开展无差别受理、同标准办理;一体化政务服务平台全面整合各级各部门业务自建系统,部门间数据共享渠道全面打通;高频电子证照在全国范围内互通互认,“免证办”得到全面推行;政务服务实现由“政府供给侧”向“社会需求侧”转变,“一件事”“一业一证”“智能审批”“免申即享”等集约化办事、智慧化服务更加科学实用,“网上办、掌上办、就近办、一次办”更加好办易办,政务服务线上线下深度融合、协调发展,方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务体系全面建成。

二、推进政务服务标准化

(一)推进政务服务事项标准化

明确政务服务事项范围。根据国家明确的政务服务事项范围和类型,规范设置全市依申请行政权力和公共服务事项范围和类型,统一纳入政务服务事项标准化、规范化、便利化管理范畴。按照《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》(国办发〔2022〕2号)和《福建省人民政府办公厅关于印发福建省行政许可事项清单(2022年版)的通知》(闽政办〔2022〕50号)要求,编制完善市、区两级行政许可事项清单,调整各级权责清单中的行政许可事项。

加强政务服务事项的标准化管理。各级审批服务部门要按照省审改办工作要求,根据福建省政务服务事项标准化目录(以下简称《标准化目录》)事项体系和实施要素标准的调整更新,及时做好认领和绑定。政务服务事项与《标准化目录》形成更高水平的事项对接、标准联动、动态调整、全面实施机制。

落实政务服务事项动态管理机制。各级审批服务部门要根据法律法规政策依据调整情况、审批服务权限下放情况或《标准化目录》更新情况,及时做好相应的调整申请或关联绑定,实现政务服务事项数据同源、动态更新、联动管理。调整更新现行政务服务事项清单,实现与《标准化目录》中的同类事项名称、类型等要素一致。

加强上级下放事项的承接落实。推动福建省下放厦门的审批权限涉及的政务服务事项稳妥有序衔接,及时调整完善权责清单和审批服务事项目录,推动相关事项入驻福建省网上办事大厅和线下办事大厅, 完善审批系统对接和数据汇聚,优化流程提升审批服务效能,加强事中事后监管。

(二)规范政务服务事项实施清单标准

各级审批服务部门要根据《标准化目录》中相关实施清单标准的调整,进行同步更新,确保已绑定发布事项符合或优于标准。执行国务院有关部门制定的"跨省通办"全程网办、异地代收代办、多地联办的流程规则,落实收件地或办理地权责,规范开展业务流转。聚焦企业群众关切,开展公共服务事项标准化梳理,明确简易公共服务事项办理方式。规范依法依规设立的地方特殊政务服务事项办理标准,对接列入福建省《标准化目录》,全面清理《标准化目录》之外的事项标准。

(三)探索建立健全政务服务标准

贯彻落实国家、省政务服务标准化工作指南及政务服务相关标准规范,注重总结政务服务创新举措, 对可复制推广的经验加以标准化提升,积极申报、争取形成全省乃至全国的政务服务标准。做好"一体化政务自助终端设置与运营管理规范"省级地方性标准的制定工作。

三、推进政务服务规范化

(一)规范审批服务

规范审批服务行为。各级审批服务部门要严格按照《标准化目录》设置政务服务事项办事指南,在现场提供办事标准查询,规范开展审批服务。在保证实际办事标准与福建省网上办事大厅公布办事指南标准一致的基础上,对办事指南相关内容添加通俗易懂的备注,对所有申请材料和结果材料提供范本。推动各部门开展前置申报辅导,分领域设置申报辅导专区(窗)。进一步强化前台人员服务规范,严格执行首问负责、一次性告知、窗口无否决权和限时办结等制度,加强日常效能督查。通过福建省网上办事大厅向社会公布依法设有现场勘验、技术审查、听证论证等特殊环节的政务服务事项清单,明确特殊环节承诺时限、设立依据等要素。

规范审批监管协同。按照"谁审批、谁监管,谁主管、谁监管"原则,健全审管衔接机制。行政许可事项要严格按照国家和省行政许可事项清单管理要求,逐项明确对应的监管部门,完善事前事中事后全链条全领域监管。依托全省一体化政务服务平台开展"审管联动",配合做好福建省网上办事大厅厦门分厅与省"互联网+监管"系统之间的数据互联互通,各级监管部门要根据行政许可办件信息有效开展监管,各级审批部门要根据监管中发现的问题依法加强审查工作针对性。翔安区要在推行相对集中行政审批权改革试点过程中,做好区行政审批局承担的审批职责与行业主管部门承担的监管职责之间的衔接联动。

规范中介服务。根据全省行政许可事项清单和政务服务领域强制性中介服务事项清单,梳理更新市级政务服务领域强制性中介服务事项清单,统一中介服务事项各要素。市、区两级审批服务部门要完善本行业领域中介服务的规范和标准,指导监督中介服务机构规范开展服务,推动

中介服务机构公开服务指南，明确服务条件、流程、时限和收费标准等要素。持续清理整治中介服务环节多、耗时长、收费乱、市场垄断、“红顶中介”等问题。加强对中介服务机构的信用监管，建立中介服务机构信用评价机制，实行信用分级分类监管和资质动态管理。依托省住建厅一体化工程建设项目审批中介服务超市，健全网上中介评价机制，规范中介服务网上交易行为。

(二)规范政务服务场所办事服务

规范政务服务场所设立。统一调整各级政务服务场所名称，区级以上为政务服务中心，镇(街道)为便民服务中心，村(社区)为便民服务站。建立政务(便民)服务中心(站)进驻事项负面清单，除场地限制、涉及国家秘密等情形外，原则上市、区级政务服务事项应全部纳入当地政务服务中心集中办理。确不具备整合条件的政务服务事项，由业务部门设立政务服务分中心，接受同级政务服务管理机构的统一业务指导，提供规范化服务。市审改办牵头各区制定本辖区便民服务中心(站)进驻事项负面清单，推动基层政务服务“一站式”办理。

规范政务服务窗口设置。完善综合咨询窗口设置，统一提供咨询、引导等服务。各级政务服务机构、业务部门分中心全面推行综合办事窗口全覆盖，根据事项关联度、办件量、群众办事习惯，按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的模式，科学设置分领域或无差别综合办事窗口。各区政务服务管理机构要强化区直部门审批服务事项综合窗口“全科受理”能力，实现无差别综合办事窗口全覆盖。优化人员配备，推动各部门全面细化梳理受理审查要点，组织开展业务培训，提升“一窗受理、综合服务”标准化、规范化、便利化水平。设立服务特殊群体窗口，为老弱病残孕提供“帮代办”服务。规范设置“跨省通办”“省内通办”“全市通办”等“跨域通办”窗口，按标准提供异地通办、全市通办服务。持续规范“办不成事”反映窗口建设，协调解决企业群众办理政务服务事项过程中的堵点、难点问题。

规范政务服务窗口业务办理。严格落实“三集中、三到位”管理要求，落实部门业务综合授权的“首席事务代表”制度，严查“在受理环节前开展实质性审查”“收件流向原审批部门”等“体外循环”现象。完善窗口收件服务标准化制度，充分授权窗口工作人员对申请材料齐全、符合法定形式的办件当场出具“业务受理通知书”，落实“收件即受理”；对申请材料不齐全或者不符合法定形式的办件，原则上当场出具“一次性告知书”，申请材料较复杂的，应做好收件登记并在3个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容；逾期不告知的，自收到申请材料之日起视为受理。市、区政务服务管理机构应持续提升窗口人员业务能力，对于无需开展特殊环节、集体审议的简单审批事项，原则上实行即来即办、“立等可取”。

(三)规范网上办事服务

统筹网上办事入口。依托福建省网上办事大厅，统一提供政务服务，规范各自建政务服务系统与省社会用户实名认证和授权平台对接跳转，确保“一次注册、多点互认、全网通行”。贯彻落实《国务院办公厅关于印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南的通知》(国办函〔2021〕105号)要求，以闽政通APP为主渠道，整合全市各类政务服务移动端应用，实现政务服务平台移动端统一对外提供服务。推进福建省网办事大厅、闽政通APP的适老化、无障碍改造。

规范网上办事指引。以用户体验为导向，进一步完善福建省网上办事大厅厦门旗舰店，优化界面设计，完善特色场景服务。依托厦门市一体化政务服务平台，建设智能导引管理系统，支撑省网厅厦门旗舰店场景导航类特色模块，进一步完善网上办事引导功能，实现“一看就能懂、一点就能办”。

提升网上办事深度。通过数据共享、告知承诺等方式，最大程度取消办件过程中纸质材料收取。推动各级各部门加大办事环节精简和流程再造力度，提升政务服务事项网上办理深度，提供申请受理、审查决定、结果送达等全流程、全环节网上服务，推动政务服务全流程网办事项占比进一步提升，由网上可办向全程网办、好办易办转变。2022年，除涉密或法律法规明确规定必须现场办理的事项外，全市政务服务事项全程网办率保持在80%以上，行政许可事项全程网办率保持在80%以上。加强对“全程网办”便捷性和办理方

式的宣传,引导办事群众更多通过线上方式申办政务服务事项。

(四)规范政务服务线上线下融合发展

规范政务服务办理方式。持续优化政务服务线上线下融合发展,满足企业和群众的多样化办事需求。审批服务部门在开通线上受理方式的同时,要同步提供线下窗口办事服务。不得强制要求申请人在线下办理业务时,先到线上预约或在线提交申请材料。已在线收取申请材料或通过部门间共享能获取规范化电子材料的,不得要求申请人重复提交纸质材料。

合理配置政务服务资源。实现政务服务网络全覆盖,确保各级政务服务机构均可依托全省一体化政务服务平台开展政务服务、共享政务数据资源。优化政务服务场所资源配置,建立线下网办专区,推动窗口人员服务前移,为申请人提供现场网办指引,优化线上线下"双渠道"服务供应。落实政务服务事项、办事指南等线上线下同源发布、同步更新,线上线下无差别受理、同标准办理。

(五)规范开展政务服务评估评价

完善政务服务线上线下"好差评"工作机制,推行企业群众线上办事 "一事一评", 线下办事"一次一评"。加强"好差评"数据汇聚,确保评价数据真实、安全、可靠,能全覆盖并真实反映全市办件评价情况,建立"好差评"全流程闭环工作机制。坚持评价人自愿自主评价原则,严查"虚假评价"问题。建立健全政务服务绩效考核机制,将政务服务便利度、"放管服" 改革、互联网+政务服务、审批服务效率、政务服务满意率等纳入全市"行政服务质量"绩效考核指标。结合常态化暗访工作机制,委托第三方开展政务服务线上线下办事体验, 并根据反馈意见对照整改提升政务服务。

四、推进政务服务便利化

(一) 推进政务服务事项集成化办理。建设"一件事集成服务系统",通过系统对接整合和数据共享,推行场景式问卷式引导、智能填报、信息复用,减少办事环节、精简申请材料、压缩办理时限,实现"一件事""一表申请、一口受理、一网办理",持续提升"一件事"办理便利度。市级有关部门要根据省、市工作部署,在企业准营、企业简易注销、企业招收员工、高频证照变更、灵活就业、婚育、身后等领域再推出一批关联性强、办事需求量大的"一件事"事项,提供主题式、套餐式服务。在全市范围内继续开展"一业一证"改革,探索建立行业综合许可制度和行业综合监管制度,将市场主体进入特定行业涉及的多张许可证整合为一张行业综合许可证,实现"一套标准、一次告知、一窗受理、一表申请、一套材料、一证准营"。持续深化工程建设项目审批制度改革,健全完善高效便捷的工程建设项目全流程在线审批机制。

(二)推广"免证办"服务。深化电子证照应用,根据省数字办印发的《全省办事免提交证照清单(试行)》,推动清单所公布的"办事免提交"证照在线上线下办事的应用。全面开展证照梳理,通过直接取消证照材料或数据共享、在线核验等方式, 推动政府部门核发的材料免于提交,2022年实现"免证办"事项数达到500项。

(三)推动更多政务服务事项"就近办、自助办"。推动公共教育、劳动就业、社会保险、医疗卫生、养老服务、社会服务、户籍管理等领域群众经常办理且基层能有效承接的政务服务事项依法以委托受理、授权办理、帮办代办、自助办理等方式下沉至便民服务中心(站)办理。依托工业园区管委会优化提升"企业办事不出园区"服务。持续提升"e政务"自助服务,拓展事项服务范围,推动服务站点向村(社区)、园区、商场、楼宇和银行、邮政等场所延伸,2022年实现280项自助服务高频事项"就近办"。

(四)推动更多政务服务事项"网上办、掌上办"。按照"应上尽上"原则,除涉及国家秘密等情形外,推动各级审批服务部门政务服务事项全部纳入全省一体化政务服务平台管理和运行,实现各级政务服务事项全面规范入驻福建省网上办事大厅。通过建设网上受理系统或配置网上预审功能,提升非涉密政务服务事项网上可办率。聚焦疫情防控和服务老年人需要, 实现缓缴养老、失业、工伤保险费,社会保险待遇资格认证、津贴补贴领取等事项网上办理。进一步完善闽政通APP厦门频道的政务服务功能,推动各区、各部

门围绕企业和群众经常办理的政务服务事项，梳理一批事项清单并推进实现“掌上办、指尖办”，统一开发部署至闽政通，推动“跨省通办”“省内通办”事项入驻闽政通APP，力争2022年全市入驻闽政通的“掌上办”事项数大幅提升至600项。市直各审批服务部门、各区要加大对闽政通APP的应用普及推广力度，推动本级政府部门广泛开展“掌上办公”“掌上审批”“移动监管”。推进高频证照在政务服务平台移动端汇聚，并在日常生产生活各领域中应用。

（五）推行告知承诺制和容缺受理服务模式。除涉及国家安全、国家秘密、公共安全、金融业审慎监管、生态环境保护，直接关系人身健康、生命财产安全，以及重要涉外等风险较大、纠错成本较高、损害难以挽回的政务服务事项外，按照最大限度利企便民的原则推行政务服务告知承诺服务模式。统一规范告知承诺或容缺受理文书格式，明确可承诺替代或容缺受理的具体内容、要求以及违反承诺应承担的法律责任，并通过福建省网上办事大厅公布可告知承诺或容缺受理的政务服务事项清单。对实行告知承诺、容缺受理的办件，有关主管部门要加强事中事后监管，确有必要的可以开展全覆盖核查，发现不符合许可条件的，要依法调查处理，并将失信违法行为记入其信用记录，依法依规实施失信惩戒。

（六）提升智慧化精准化个性化服务水平。进一步提炼升级本市各级政务服务事项审查要点标准，为推进智能审批、压缩自由裁量空间提供精准有效的审查标准支持。依托福建省网上办事大厅厦门分厅特色创新专栏，增加智能指南导引、证照百科导引、政务地图导引、智能填表导引等特色导引服务应用，完善免申即享、秒批秒办、一码办事和统一预约特色办事服务应用。完善“一企一档”“一人一档”，实现数据共享和复用，便利企业群众办事。

（七）提供更多便利服务。各级政务服务场所要加强无障碍环境建设和改造，为老年人、残疾人等特殊群体提供便利服务。推动水、电、气、法律援助、公证、电信、广电网络、邮政快递等社会公用企事业单位入驻实体大厅，按照福建省网上办事大厅公布的服务标准开展便民服务。巩固疫情防控期经验做法，完善现场办事网上预约功能，错峰提供政务服务，减少人员聚集；通过各种措施减免群众办件收寄费用。统一政务服务场所工作时间，市、区政务服务中心、分中心工作时间为每周一至周五（除法定节日）9:00–12:00、13:00–17:00；镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务站工作时间与市直机关、事业单位工作时间保持一致。对企业群众办件需求量大、办件频率高的事项推行“周六对外轮值服务”，对每日未完成办件开展延时服务。

（八）擦亮厦门“政务心服务”品牌。传承“马上就办、真抓实干”优良作风，践行“便民、高效、公开、廉洁”的服务宗旨，引导激励各级政务服务机构窗口面向群众、服务基层，深入开展线上线下帮办代办活动，巩固深化政务服务中心窗口“倾情服务、马上就办”新风正气福建“名片”活动，开展“岗位践新风，人人是名片”大家谈等内容丰富、形式多样的实践活动，在“我为群众办实事”过程中亮出服务清单、擦亮厦门政务服务“名片”。

五、全面提升全国一体化政务服务平台服务能力

（一）加强平台建设统筹。建设“厦门市一体化政务服务平台”，通过市政务信息共享协同平台，向上对接省汇聚共享平台，实现与福建省网上办事大厅、闽政通APP，以及市、区两级政务服务业务系统对接，实现全市四级全畅通。原则上不再单独建设面向企业、群众的政务服务平台，确需单独建设业务系统的，应无条件向全省一体化政务服务平台开放数据端口，实现对接融合、数据共享。分批次整合本市各级各行业自建系统，强化一体化政务服务平台数据共享和业务集成能力。

（二）强化平台公共支撑。建设全市统一的可信电子文件系统、电子档案管理系统，推广使用全省统一的电子印章系统。规范电子证照库的监督管理、统计分析、纠错登记等工作，完善电子证照的领取、展示、授权功能，及时清理失效证照，支持电子证照及其它可信电子文件的便利化调用、精准化搜索，提升证照调取精准率。推行政务服务电子文件单套归档和电子档案单套管理，依

法明确电子档案在政务服务领域与传统载体档案具有同等法律效力。为电子文件、电子档案、电子印章等在政务服务的应用、加快电子证照归集共享应用和跨层级互通互认提供基础支撑。

(三)提升数据共享能力。全面加强数据开发利用顶层设计。完善数据资源目录,推动专题数据库目录编制;探索数据共享新机制,加强数据资源汇聚共享,推动数据资源开发利用,编制公共数据资源开放目录清单。进一步提升市、区政务信息共享协同平台功能,推进省、市、区数据平台互联互通,编制数据资产目录、联通数据交换通道、互通数据服务接口、畅通业务流程。打通各级业务部门涉及不动产登记、社会保障、户籍管理、水电气网联办、市场主体准入准营等重点领域以及人口、法人、地名、教育、婚姻、生育、住房、信用的政务数据接口, 实现跨层级数据协同共享。全市各级各部门主动将政务信息系统全面接入市政务数据汇聚共享服务体系。新建系统要按照《厦门市公共数据资源目录编制规范》,编制政务数据资源目录,在市政务信息共享协同平台登记,并将数据实时全量汇聚。对已经实现数据回流的办件信息,各级审批服务部门不得要求申请人“重复填报”、办事人员“二次录入”。

六、保障措施

(一)加强组织领导。各级各部门切实加强组织领导,层层压实责任,强化经费、人员、场地、信息化保障。明确市、区、镇(街)、村(居)四级政务服务责任体系。市、区人民政府对本辖区政务服务工作负主要责任,市、区两级审改部门要充分发挥统筹协调作用,细化任务分工,收集掌握本辖区工作开展情况,督促部门按照指导意见和实施方案开展工作, 推动解决有关重点难点问题,确保任务尽快落地见效。镇人民政府(街道办事处)、村委会(社区居委会)负责本辖区政务服务具体工作,接受上级政务服务管理机构的指导和监督。

(二)明确责任分工。市审改办负责全市政务服务工作的指导协调和监督考核,承担对全市政务服务机构及一体化政务服务平台的业务指导和监督工作,统筹政务服务工作考评指标,建立健全政务服务工作制度。市委编办负责指导全市各级各部门的权责清单编制工作,明确部门权责界限,推动政府部门依权责开展政务服务。市委网信办负责统筹协调政务数据安全的重大事项和重大工作,会同市工信局、公安局、国安局、机要保密局等部门建立政务数据共享安全工作机制,共同开展网络数据安全监管,协调有关部门加强政务数据共享安全风险信息的获取、分析、研判、预警工作。市工信局(大数据局、数字办)负责做好政务服务信息化建设的基础支撑,建立健全政务数据共享协调机制,加强政务大数据的开发和应用,推进政务数据目录编制、电子证照平台、数据共享协同平台的建设、对接、改造、升级等工作。市司法局会同市审改办开展与推进政务服务不相适应的地方性法规、规章和规范性文件的清理工作。市效能督查办负责将政务服务情况纳入效能督查范围,配合市行政审批管理局共同督促政务服务标准化、规范化、便利化工作落实。市级审批服务部门负责研究规范统一主管行业领域的政务服务事项标准,指导本系统区级及以下审批服务部门规范开展政务服务。各级政务服务管理机构负责本辖区审批服务部门派驻人员的日常管理、服务规范和年度考核;对本级及下级政务服务机构的政务服务行为进行监督检查并实施电子监察;对进驻单位窗口工作情况进行绩效考评,考评情况纳入本级政府对进驻单位的绩效考评结果。

(三)加强人员队伍建设

强化政务服务管理机构人员力量。各级政府要强化对本级政务服务管理机构的人员力量配备,加强人才引进和经费保障。市、区两级政务服务管理机构要负责对直属政务服务机构的综合窗口人员进行统一配备,探索推进基层便民服务中心(站)窗口工作人员由区政务服务管理机构统一配备。

稳定政务服务机构人员队伍。各单位在干部选任工作中,应主动征求政务服务管理机构对派驻人员的意见。各级政务服务管理机构对实行政府购买服务的办事窗口,要健全完善和督促落实相关服务标准,对窗口工作人员按照行政办事员(政务服务综合窗口办事员) 国家职业技能标准探索开展等级认定、定岗晋级等工作,增强人员队伍的稳定性。市、区政务服务管理机构每年对本辖区政务服务机构人员开展不少于1次的业务

轮训,提高政务服务人员业务水平。

加强政务服务信息化平台队伍建设。加强一体化政务服务平台运营管理队伍建设,强化各级政务服务平台技术运维人员力量配备。

(四)加强法治保障。全面贯彻实施国家、省、市有关优化营商环境法规,聚焦政务服务优化面临的政策制度障碍,及时清理与推进政务服务标准化、规范化、便利化不相适应的地方性法规、政府规章和规范性文件。推动将行之有效并可长期坚持的做法以立法形式予以固化,发挥法治引领和保障作用。

(五)加强安全保障。强化政务服务平台安全保障系统建设,落实安全管理主体责任,分级做好政务服务平台建设运营和网络数据安全保障工作,构建全方位、多层次、一致性的安全防护体系,不断提升一体化政务服务平台风险防控能力。加强政务数据全生命周期安全防护,强化政务服务和数据共享利用中的个人隐私、商业秘密保护,确保政务网络和数据安全。

(六)加强宣传推广。全市各级各部门要加强政策宣传,通过政府网站、政务新媒体、政务服务平台等向社会提供通俗易懂的政策解读。要及时总结提炼本区、本部门推进政务服务标准化、规范化、便利化工作的进展成效和经验做法,并向市审改办报送。

本实施方案自发布之日起施行,有效期至2025年12月31日。

附件:厦门市加快推进政务服务标准化规范化便利化的具体任务分工(略)

厦门市人民政府关于印发厦门市医疗救助办法的通知

厦府规〔2022〕14号

各区人民政府,市直各委、办、局,各开发区管委会,各有关单位:

《厦门市医疗救助办法》已经第26次市政府常务会议研究通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。

厦门市人民政府

2022年11月22日

厦门市医疗救助办法

第一章 总 则

第一条 为进一步完善医疗救助制度,切实减轻困难群众和大病患者医疗费用负担,建立健全防范化解因病致贫返贫长效机制,根据国家、省有关规定,结合本市实际,制定本办法。

第二条 医疗救助遵循下列基本原则:

(一)属地管理、分级负责;

(二)公平适度、托住底线、高效便捷;

(三)救助水平与经济社会发展水平相适应。

第三条 市医疗保障行政部门负责本办法的组织实施,统筹推进基本医疗保险、大病保险及医疗救助。医疗保障经办机构负责医疗救助的经办服务及管理。

民政、卫生健康、乡村振兴、残联、退役军人事务等部门依据各自职责,负责相关医疗救助对象认定及信息共享,协同做好医疗救助工作。

民政部门负责临时救助及慈善救助工作。

财政部门负责医疗救助资金保障及医疗救助资金监管。

卫生健康部门负责医疗机构行业监管,规范医疗服务行为。

税务部门负责基本医疗保险费征缴和资助参保工作,提供多元化、便利化参保缴费服务。

乡村振兴部门负责农村易返贫致贫人口监测。

总工会负责职工医疗互助和罹患大病困难职工帮扶。

审计部门负责医疗救助资金审计监督。

银保监部门负责商业健康保险的规范及监管。

街道办事处、镇人民政府〔以下简称街道(镇)〕负责医疗救助的申请受理和调查审核。

居(村)民委员会协助街道(镇)做好医疗救助对象的主动发现、协助申请、调查核实、公示等工作。

第四条 鼓励和引导商业健康保险、医疗互助以及慈善救助等社会力量参与医疗救助保障。

第二章 医疗救助对象

第五条 本办法所称的医疗救助对象,是指符合救助条件的困难职工和城乡居民,具体包括:

第一类:特困供养人员、孤儿(含事实无人抚养儿童);

第二类:重点优抚对象、革命"五老"人员、计划生育特殊家庭成员、重度残疾人;

第三类:最低生活保障对象、纳入乡村振兴部门监测的农村易致贫返贫人员、脱贫(享受政策)人员;

第四类:最低生活保障边缘家庭成员;

第五类:不符合上述四类医疗救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(以下简称"因病致贫重病患者")。

同时符合多重救助身份的人员按待遇就高原则给予救助,不得重复享受医疗救助待遇。

第六条 因病致贫重病患者认定应同时符合以下条件:

(一)申请前12个月政策范围内医疗费用个人自付达到或超过本市上年度居民人均可支配收入的;

(二)申请前12个月的家庭总收入扣除家庭成员个人负担的医疗费用后,家庭人均收入低于本市最低生活保障边缘家庭标准;

(三)家庭财产符合本市最低生活保障边缘家庭条件。

第七条 第一类医疗救助对象特困供养人员、孤儿(含事实无人抚养儿童)由民政部门认定。

第二类医疗救助对象中的重点优抚对象由退役军人事务部门认定;革命"五老"人员由民政部门认定;计划生育特殊家庭成员由卫生健康部门认定;重度残疾人由残联认定。

第三类医疗救助对象中的最低生活保障对象由民政部门认定;农村易致贫返贫人员、脱贫(享受政策)人员由乡村振兴部门认定。

第四类医疗救助对象中的最低生活保障边缘家庭成员由民政部门认定。

第五类医疗救助对象中的因病致贫重病患者由民政部门会同医疗保障经办机构认定。

第八条 医疗保障经办机构全面开展参保人员高额医疗费用支出预警监测,重点监测经基本医疗保险、大病保险等支付后个人医疗费用负担仍然较重的低保边缘家庭成员和农村脱贫人口,将预警监测情况信息推送给同级民政、乡村振兴等部门。民政、乡村振兴部门应及时核实确认,符合医疗救助对象认定条件的,反馈至医疗保障经办机构纳入医疗救助范围。

第九条 参保人员高额医疗费用支出预警监测标准按照国家、省有关规定执行。

第十条 民政、卫生健康、乡村振兴、残联、退役军人事务等医疗救助对象认定责任部门,应建立相应的人员信息库,并负责医疗救助对象信息比对校验、动态维护、及时更新及数据共享,每月

15日前各部门应当将认定核准的医疗救助对象名单发送至医疗保障经办机构。

医疗保障经办机构负责建立和管理困难群众参保台账,动态标识医保信息系统身份后传送至税务部门,及时纳入资助参保范围。

第三章 医疗救助方式及标准

第十一条 实行城乡居民基本医疗保险参保财政补助政策,对个人缴费确有困难的群众按规定给予分类资助。其中,对第一、二类医疗救助对象给予全额资助; 对第三类医疗救助对象按照90%比例给予定额资助。

第十二条 对符合条件的新增医疗救助对象应及时认定并资助参保,相关待遇从认定之日的次月起执行;认定前个人当年已参保的,不再资助参保。

第十三条 对享受资助的医疗救助对象中因个人原因放弃参保的,应做好参保动员,提高其参保积极性;经相关部门多次动员后仍不按规定缴费参保的,视为放弃当年参保和享受基本医疗保险、大病保险及医疗救助待遇。

第十四条 实行门诊和住院救助。医疗救助对象在定点医疗机构门诊和住院、在定点零售药店购买“双通道”药品,发生符合基本医疗保险规定的医疗费用,扣除基本医疗保险、大病保险等已支付的金额,对个人自付医疗费用给予一定比例救助。

第十五条 医疗救助对象发生以下政策范围内医疗费用,纳入个人自付医疗费用及医疗救助待遇计算范围:

(一)基本医疗保险门诊、住院起付标准以下的医疗费用;

(二)基本医疗保险起付标准以上、统筹基金最高支付限额以下由个人按比例负担的医疗费用;

(三) 基本医疗保险统筹基金最高支付限额以上的医疗费用;

(四)医保目录乙类范围的药品、医用耗材、医疗服务项目按比例先由个人支付部分,以及药品和医用耗材医保支付标准以上最高销售限价以下部分的医疗费用。

第十六条 医疗救助对象发生以下医疗费用,不纳入个人自付医疗费用及医疗救助待遇计算范围:

(一)在非定点医药机构发生的(急诊和抢救除外);

(二)应当从工伤保险基金中支付的;

(三)应当由第三人负担的;

(四)应当由公共卫生负担的;

(五)在境外就医的;

(六)体育健身、养生保健消费、健康体检;

(七)国家、省规定的基本医疗保险基金不予支付的其他费用。

第十七条 医疗救助标准如下:

(一)起付标准

1.第一、二、三类医疗救助对象不设救助起付标准;

2.第四类医疗救助对象按6000元确定;

3.第五类医疗救助对象按16000元确定。

(二)救助限额

门诊和住院救助共用年度救助限额,除第一类医疗救助对象不设年度救助限额以外, 第二、三、四、五类医疗救助对象的年度救助限额为13万元,超过年度救助限额后医疗救助基金不再支付。

(三)救助比例

在年度救助限额内,统一门诊和住院救助比例:

1.第一类医疗救助对象救助比例100%;

2.第二类医疗救助对象救助比例95%;

3.第三类医疗救助对象救助比例95%;

4.第四类医疗救助对象救助比例85%;

5.第五类医疗救助对象救助比例50%。

第十八条 对经基本医疗保险、大病保险和医疗救助三重制度综合保障后政策范围内的医疗费用个人负担仍然较重,导致基本生活严重困难的医疗救助对象,每年度根据医疗救助资金结余情况,实行依申请一次性倾斜救助。

第十九条 根据国家、省的有关规定和本市经济社会发展水平以及医疗救助资金的运行情况,市医疗保障行政部门可会同市财政、民政部

门对本办法中的医疗救助保障、就医结算、监管和服务等提出调整方案,经市人民政府同意后实施。

第四章 医疗救助服务

第二十条 医疗保障定点医疗机构的医疗救助工作纳入定点医疗机构协议管理,接受医疗保障部门管理监督。

第二十一条 定点医疗机构应完善并落实各项诊疗规范和管理制度,严格执行医保药品、医用耗材和医疗服务项目等目录,合理诊疗、合理检查、合理用药、合理收费,合理控制医疗费用及个人自费比例,减轻患者就医负担,提升医疗服务质量。定点医疗机构不得要求医疗救助对象支付按规定应予减免的费用。

定点医疗机构应提供长期处方服务,推进检查检验结果互认,不断改善群众医疗服务体验。

第二十二条 第一、二、三、四类医疗救助对象不需申请,持本人医疗保障凭证到定点医疗机构就诊,定点医疗机构按照医疗救助有关规定,为医疗救助对象提供医疗费用"一站式"即时结算服务,应由医疗救助对象个人支付的医疗费用,由个人支付给定点医疗机构;应由医疗救助资金支付的医疗费用,由医疗保障经办机构与定点医疗机构按规定结算。

第二十三条 第五类医疗救助对象实行依申请一次性救助制度,医疗保障经办机构根据民政部门提供的名单实施医疗救助,具体申请和审核审批程序按照国家、省有关规定执行。

第二十四条 第一、二、三类医疗救助对象在本市定点医疗机构住院期间,实行"先诊疗后付费",免除住院押金;其他医疗救助对象在本市定点医疗机构住院期间,适当减免住院押金。

第二十五条 建立临时救助与医疗救助衔接机制,民政部门负责临时救助工作。

(一)非本市基本医疗保险参保人员,经认定为本市医疗救助对象的,按规定执行本市医疗救助标准;

(二)其他因医疗费用负担符合临时救助条件,经民政部门认定为临时救助对象的,按规定执行本市临时救助标准。

救助对象按临时救助程序向户籍(居住)地街道(镇)申请救助,民政部门按临时救助程序审批发放救助费用。

第二十六条 医疗保障经办机构依托医疗保障信息平台,深化基本医疗保险、大病保险和医疗救助服务融合,提升服务质效。相关部门应建立救助服务事项清单,优化救助经办管理服务规程,协同做好医疗救助对象认定信息共享互认、资助参保、待遇给付等经办服务。

第二十七条 卫生健康部门应加强对定点医疗机构监督管理,规范医疗服务行为,指导督促定点医疗机构优先配备使用医保目录药品及适宜诊疗技术,促进合理诊疗、因病施治,控制医疗费用不合理增长,减轻困难群众医疗费用负担,提高救助资金使用效率。

第五章 资金筹集

第二十八条 医疗救助资金按规定由市、区财政承担,并根据经济社会发展水平、财政承受能力、医疗保障水平等及时足额保障医疗救助资金。医疗救助资金来源包括财政预算资金、彩票公益金、社会捐赠资金、救助资金利息收入等。医疗救助资金由市财政部门统一筹集、统一拨付给市医疗保障经办机构,市、区财政部门的医疗救助资金通过财政体制结算。

第二十九条 医疗保障经办机构应根据本市医疗救助对象人数、救助资金筹资负担标准和上年度医疗救助资金支出情况,编制年度医疗救助资金预算,报市财政部门审核安排。

第三十条 医疗救助资金实行专户管理、专款专用,不得列支其他费用。医疗保障经办机构应建立医疗救助资金专账,救助资金各项收入和支出实行专账核算、专项管理。年度医疗救助资金预算不足的,应及时追加;年度医疗救助资金有结余的,应结转下年度使用。(下转第39页)

厦门市人民政府关于印发贯彻落实国务院计量发展规划(2021–2035年)实施方案的通知

厦府〔2022〕364号

各区人民政府,市直各委、办、局,各开发区管委会,各有关单位:

《厦门市贯彻落实国务院〈计量发展规划(2021–2035年)〉实施方案》已经市政府研究,现印发给你们,请认真贯彻实施。

厦门市人民政府

2022年11月21日

厦门市贯彻落实国务院《计量发展规划(2021–2035年)》实施方案

计量是实现单位统一、保证量值准确可靠的活动,是科技创新、产业发展、国防建设、民生保障的重要基础,是构建一体化国家战略体系和能力的重要支撑。为贯彻落实《国务院关于印发计量发展规划(2021–2035年)的通知》(国发〔2021〕37号)、《福建省人民政府关于贯彻落实国务院<计量发展规划(2021–2035年)>的实施意见》(闽政〔2022〕20号),根据《厦门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》(厦府〔2021〕57号)精神,结合厦门计量工作实际,制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,围绕厦门市“五中心一基地”建设,以重大需求为牵引,以服务产业为主攻方向,充分调动社会各方资源和力量,坚持科技创新、体制改革双轮驱动,坚持需求牵引、供给提升双向发力,坚持政府统筹、市场驱动双重作用,加快构建城市现代先进测量体系,形成全社会共建、共治、共享的计量发展新格局,为全方位推进高质量发展、率先实现社会主义现代化提供坚实的计量支撑和保障。

二、发展目标

到2025年,本市现代先进测量体系初步建立,科研创新能力、计量服务保障能力和计量监管水平显著提升,部分领域达到国内领先水平。计量在经济社会各领域的地位和作用日益凸显,协同推进计量工作的体制机制进一步完善。

到2035年,本市计量科技创新水平大幅提升,关键领域计量技术取得重大突破,部分领域达到国际先进水平。计量服务保障能力大幅增强,现代计量治理体系进一步健全,符合时代发展需要的城市现代先进测量体系基本建成。

三、重点任务

(一)加强计量基础研究,推动科技创新发展

1.开展计量数字化转型研究。加强国家计量科学数据中心厦门分中心建设,开展计量数据的统计、分析和利用,提升数字资源服务水平,为“数字厦门”建设提供计量支撑。研究制定计量科学数据管理办法和标准规范,保障计量数据的溯源性、准确性和安全性。推动计量数字化转型,在平板显示、海洋高端装备、新能源汽车等领域开

专栏 1：计量发展主要指标			
指标	2020 年	2025 年	属性
省、市计量比对主导项（项）	6	16	预期性
社会公用计量标准（项）	180	230	预期性
主持及参与省部级及以上计量科研项目（项）	9	14	预期性
计量相关专利（项）	42	80	预期性
国家级计量中心（个）	1	2	预期性
省级产业计量测试中心（个）	--	1	预期性
主持及参与计量技术规范（项）	44	53	预期性
国家标准物质（项）	--	20	预期性
引导培育诚信计量自我承诺单位（家）	506	850	预期性

展数字化计量技术研究，推动跨行业、跨领域计量数据融合、共享与应用，为行政监管、产业发展、绿色低碳提供科学指导。（责任单位：市市场监管局、市科技局、市工信局、市海洋局）

专栏 2：计量数字化转型重点工作
1.推进计量数据汇聚共享。依托国家计量科学数据中心厦门分中心，健全计量数据管理制度，推进计量数据资源场景开发和授权开放，建立金砖国家、海峡两岸等计量信息资源库，促进多方在计量政策研究、计量溯源体系建设等方面的协同和互联互通。 **2.加强计量数据融合应用。**围绕产业升级、质量提升、民生改善、行政监管等方面数字化转型中的计量需求，推动智能化计量器具研发、计量测试过程自动化、质量控制体系智慧化、计量证书及报告电子化等课题研究。推广智慧计量理念，推动企业开展测量设备智能化、数字化升级改造。

2.开展新型量值传递溯源技术研究。针对复杂环境、实时工况环境和极端环境的计量需求，加强量值传递溯源方法的研究，解决综合参量的准确测量难题。开展产业急需的计量溯源技术创新，自主研制计量标准装置和标准物质。加强先进计量应用技术研究，满足产业关键性能参数测试能力要求。（责任单位：市市场监管局）

专栏 3：新型量值传递溯源技术研究重点工作
1.计量测试方法研究。开展在线计量、动态计量、嵌入式计量、远程计量、多参数综合测量、跨尺度测量以及基于深度学习和AI算法的机器视觉检测等新型计量测试方法研究。 **2.计量标准装置研制。**自主研制计量标准装置和标准物质，搭建产业计量创新平台，研制全自动偏光测试仪、高精度温度计、跨尺度微纳形貌测量仪和多自由度传感器等高端通用计量仪器设备。 **3.计量应用技术研究。**加强产业计量应用领域薄弱环节的技术研究，重点研究在线式图像尺寸测量、微纳米几何量精密测量、空间大尺寸位姿测量等计量应用技术。

3.加强标准物质研制应用。加快生物医药、环境监测、食品安全等重点领域的标准物质研制和应用。加强标准物质关键共性技术研究，提升标准物质不确定度水平。探索建立标准物质质量追溯制度，开展标准物质量值核查验证。（责任单位：市市场监管局、海洋三所、厦门大学）

专栏4：标准物质研制应用重点工作

1.生物医药领域。研制甘露醇、角鲨烯等纯度相关的临床化学分析与药品成分标准物质。

2.环境监测领域。研制空气（氮）中一氧化碳等环境化学分析相关气体标准物质。

3.食品安全领域。研制岩藻糖、N-乙酰-D-氨基葡萄糖、海洋藻类毒素等食品标准物质领域纯度相关标准物质。

4.加强计量科技创新生态建设。发挥科研院所及综合性、行业性科技创新平台的引领和导向作用，释放企事业单位技术创新活力，推进高水平计量基础设施建设，支持申报平板显示计量测试等重点实验室。推进产学研用计量科技合作，促进科技成果转化。深化计量技术特派员服务，构建计量测试与产业同频共振、协同发展的格局。（责任单位：市市场监管局、市科技局、市财政局、厦门大学）

（二）强化计量应用提升，服务重点产业发展

5.支撑实体经济高质量发展。开展产业计量基础能力提升行动，实施计量服务实体经济行动，发挥计量对产业发展的支撑保障作用。重点围绕全市“4+4+6”现代产业体系，开展制造业计量能力提升工程。提升各级产业计量测试中心、重点实验室、联盟等能力建设，为产业提供全溯源链、全产业链、全寿命周期并具有前瞻性的计量测试服务。（责任单位：市市场监管局）

6.引领平板显示产业发展。发挥国家平板显示产业计量测试中心（厦门）的支撑和引领作用，为平板显示产业全产业链提供定制化、多元化、数字化的“一站式”服务。加强平板显示产业计量测试技术、测试方法和专用装备的研究，填补新领域计量测试技术空白。加强全国显示产业计量测试联盟建设，开展学术交流，促进资源共享，联合项目攻关。依托产业计量测试公共服务平台，建立技术对接渠道，提升精准可靠的计量测试服务供给水平。（责任单位：市市场监管局、市科技局、市财政局）

专栏5：服务平板显示产业发展重点工作

1.加强平板显示前瞻性计量测试研究。在Micro-LED、AR/VR虚拟现实、人工智能、柔性触控显示、透明显示、视觉健康等平板显示新兴领域开展关键参数计量测试方法研究和装备研制，完善量值传递溯源体系。

2.完善平板显示产业计量技术规范和标准化体系。加快制定透明显示、触控屏、显示玻璃等平板显示产业相关计量技术规范和标准，引导产业标准化、规范化发展。

3.开展显示产业计量测试联盟关键产品及测试仪器评价工作。开展近眼显示、柔性触摸、摄像头、显示用光谱亮度计、移动终端显示性能等测试评价工作，建立显示产业计量测试评价体系。

7.提升海洋高端装备领域计量保障能力。加快“福建省海洋高端装备产业计量测试中心”建设,服务海洋高端装备产业全溯源链、全寿命周期和全产业链,解决产业转型升级中的计量测试难题。完善海洋高端装备产业计量测试服务体系,加强产业计量科研创新能力,搭建海洋高端装备产业计量创新平台。紧密结合产业关键领域和关键参数测量技术需求,开展前瞻性计量测试技术研究。紧盯海洋高端装备产业难点痛点,开展科技项目攻关,研制产业专用测量装备。(责任单位:市市场监管局、市海洋局、市科技局)

专栏6:海洋高端装备产业计量保障重点工作
1.完善产业计量服务体系。开展无损探伤计量、涂料理化性能检测、微纳米几何量精密测量、空间大尺寸位姿检测和远洋导航终端溯源等产业计量测试实验室建设。 **2.前瞻性计量测试技术研究。**开展复合材料力学环境可靠性测试、涂料理化性能和有害物质检测、船体形变测量、叶片自由曲面扫描、传动轴系对中等前瞻性计量测试技术研究。 **3.产业专用测量装备研制。**开展全站仪自动化辅助检定装置、车船防护玻璃冲击测试仪、体式显微镜校准装置、平板式电热恒温系统校准装置等专用测量装备研制。

8.服务半导体与集成电路产业发展。加强半导体与集成电路产业计量测试能力建设,开展半导体芯片多参量综合测试、器件失效分析、可靠性验证等技术研究,提升半导体材料光学检测、微纳米几何量精密测量等计量服务水平。充分发挥厦门大学国家集成电路产教融合等创新平台优势,深化产学研用合作创新,加快集成电路领域关键核心技术攻关。(责任单位:市市场监管局、市工信局、厦门大学、市科技局)

专栏7:服务半导体与集成电路产业发展重点工作
1.完善LED半导体产业的计量测试能力。开展微型LED芯片二维光色热综合检测、非接触式电特性检测等计量测试技术研究。建立UV-LED紫外辐射度计量体系,开展UV-LED辐射度计量技术研究。 **2.加强微纳米测量领域计量测试技术研究。**开展原子力显微镜、扫描电子显微镜、透射电子显微镜等微纳米结构测量设备的计量技术方法、标准装置研究。开展集成电路芯片缺陷在线检测技术及在线式微纳米测量系统溯源方法等计量技术研究。

9.推动生物医药与健康产业发展。围绕“生物医药与健康”千亿产业链重点发展方向,在疾病防控、生物医药、高端医疗器械、营养与保健食品等领域开展关键计量测试技术研究和应用。加强疫情防控、冷链物流等相关设备的计量测试能力,完善生物医药计量仪器的溯源体系。加快医疗领域计量服务体系建设,提升医疗领域精准、个性及定制化计量测试服务能力。(责任单位:市市场监管局、市卫健委、市科技局)

专栏8：服务生物医药与健康产业重点工作

1.完善医疗器械领域的计量测试能力。开展高值医疗植入物、体外诊断试剂与设备、高端医疗装备的关键参数测量及其量值溯源技术研究。

2.加强创新药物领域计量测试技术研究。开展化学药、生物药、中药和天然药物、生物前沿治疗等成分及结构测量设备的计量技术方法、标准物质研究。

3.提升营养与保健食品领域关键计量测试技术能力。开展食品标准物质领域纯度相关标准物质研究。

10.服务碳达峰碳中和目标实现。加强碳排放关键计量测试技术、低碳绿色循环计量方法学研究与应用。建设碳计量标准装置，加强关键共性和重点领域计量技术研究，提升碳计量量传溯源能力。积极参与和开展能源计量相关标准、规程规范的制修订。加强能源计量审查，强化能源资源计量数据分析应用。加大新能源汽车等低碳绿色产业计量测试能力建设，提升新能源电池、高压大电流领域检定校准能力，开展充电桩等在线计量技术研究。（责任单位：市市场监管局、市工信局、国网厦门供电公司）

11.提升城市轨道交通运输服务产业计量保障能力。开展轨道交通计量技术攻关与测量装备研发，解决复杂工况和实时在线轨道交通计量器具和测量设备的计量溯源。加强轨道交通行业计量测试能力、计量科技创新能力和运行能力建设。汇聚计量技术机构、企业等优势资源，建立联合实验室等创新载体，开展人才培养、项目攻关等合作。（责任单位：市市场监管局、市交通局、市地铁办、轨道集团）

专栏9：城市轨道交通运输服务产业计量保障重点工作

1.计量量值溯源服务。建立铁路轨距尺检定装置、铁路支距尺检定装置、铁路轮对内距尺检定装置等专用计量标准，开展专用计量器具的检定和校准工作。

2.产业关键参数测试。开展扣件组装性能的检测、疏散平台检测、设备设施几何参数检测和材料微观组织结构分析及地铁能源计量器具数据准确性及传输稳定性研究。

3.计量测试方法研究。研究尖轨降低值测量仪、轨底坡测量仪等轨道专用仪器设备的计量测试方法或校准规范。

（三）加强计量能力建设，赋能高质量发展

12.构建新型量值传递溯源体系。积极应对国际单位制的变革和量值传递溯源的数字化、扁平化要求，逐步构建政府统筹、依法管理的量值传递体系和市场需求导向的量值溯源体系。统筹规划建设全市社会公用计量标准，建立微纳米几何量、全球定位系统、光辐射、光通信和电磁兼容等领域的一批高精度、高稳定性的计量标准，填补我市产业应用领域的量值传递空白。开展计量溯源方法研究和标准器研制，完善产业溯源链，提升量值溯源效能，满足市场对量值溯源和测试服务的需求。（责任单位：市市场监管局）

13.推进计量标准建设。科学规划计量标准建设，加快经济社会发展、产业转型升级、保障民生需求等重点领域计量标准研究，填补量传溯源体系空白，推进计量标准技术改造和升级换代。

探索建立智能化、小型化的计量标准，推动对制造过程的实时在线测量。(责任单位：市市场监管局)

14.加快计量技术机构能力建设。加快法定计量技术机构能力提升，加强普惠性、基础性和公益性计量基础设施建设。充分利用市场资源和力量，构建多元、开放的计量新格局，推动计量服务市场健康发展。鼓励计量技术机构建立智能计量管理系统，实施设备的自动化、数字化改造，探索建设智慧计量实验室。支持建设国家平板显示产业计量比对中心。(责任单位：市市场监管局)

15.加强计量人才队伍建设。加强政检校企、产学研用合作，推动计量技术人才联合培养与双向流动，培养复合型、应用型等多元化发展的技术人才。实施计量人才提升行动，鼓励社会各方力量建立计量培训平台、实训基地、研究生工作站，打造高技能型、实用型的计量技术人才。建立市计量专家人才库，吸引国内外“高精尖”专家共同参与重点项目建设。鼓励计量技术机构创新岗位设置，建立首席计量师等聘任制度，提升计量队伍的专业水平。(责任单位：市市场监管局、市人社局、厦门大学、市教育局)

16.完善企业计量体系。引导企业加强计量基础设施建设，合理配置计量仪器设备，建立完善计量管理制度和保障体系，加大企业计量人才培养力度。推行企业计量能力自我声明制度。指导企业加强对计量数据的应用和管理，实现对生产全过程的精细化管理，促进节能减排、提质增效，鼓励企业通过测量管理体系认证。发挥产业计量优势，落实中小企业计量伙伴计划，开展计量服务中小企业活动，提升产业链相关中小企业计量保证能力。(责任单位：市市场监管局、市工信局)

17.建立两岸计量合作机制。落实台湾地区甲级、乙级计量技术人员职业资格采认工作制度，打造台胞台企登录第一家园第一站。积极研究制定两岸优势产业相关标准、技术规范和测试方法。加强与台湾计量组织、台资企业共同开展人才交流、技术装备研发、产品测试技术创新、计量技术规范制定等项目合作。(责任单位：市市场监管局、市人社局)

18.加强计量国际交流合作。开展金砖国家计量国别政策研究，提供技术咨询和政策解读服务。聚焦金砖创新基地重点发展产业，为企业在攻关测试技术、完善质量体系等方面提供计量测试服务。在LED、平板显示等领域积极开展金砖国家计量项目合作。开展测量领域及厦门优势产业WTO/TBT技术贸易通报评议及分析并定期发布相关分析报告。(责任单位：市市场监管局、市金砖办)

(四)加强计量监督管理，提升计量监管效能

19.创新计量监管模式。探索建立新型计量监管模式和制度，推动监管重点从管器具向管数据、管行为、管结果的全链条计量监管方式转变。积极稳妥推进试点取消“承担国家法定计量检定机构任务授权”许可改革。落实市场主体计量风险管控主体责任，强化计量风险防范意识，快速有效处置计量突发事件。(责任单位：市市场监管局)

20.强化民生计量监督管理。实施计量惠民工程，督促法定计量检定机构履行强制检定职责。定期组织开展集贸市场、加油(气)站、海鲜大排档、商超、医疗机构、眼镜制配场所等重点领域专项监督检查。强化对定量包装商品生产企业的计量监管，持续开展定量包装商品净含量计量监督专项检查。围绕实施乡村振兴战略，加大对衡器、水分测定仪、谷物容重器等涉农计量器具的计量监管。(责任单位：市市场监管局、市交通局、市卫健委)

21.建立诚信计量长效机制。完善诚信计量体系，建立“经营者自我承诺、政府部门推动引导、社会各界监督”三位一体的诚信计量管理模式。强化市场经营主体责任，推行经营者诚信计量自我承诺。在眼镜制配、加油站、商超、医疗机构等商业、服务业领域开展诚信计量行动。实施计量信用监管、“双随机、一公开”监管，强化严重违法失信名单管理，真正发挥守信激励和失信惩戒的作用。(责任单位：市市场监管局、市发改委、市商务局、市卫健委)

22.严厉打击计量违法违规行为。加强计量业务监管与综合执法的衔接，行政执法与刑事司法衔接，加大对计量违法行为的打击力度。加强计量作弊防控技术和查处技术研究，严厉查处制造、销售和使用带有作弊功能计量器具的违法行

为。规范计量服务行为,严厉打击伪造计量数据、出具虚假计量证书和报告的违法行为。(责任单位:市市场监管局、市公安局)

四、保障措施

23.加强组织领导。坚持党对计量工作的全面领导,各区人民政府和有关部门要高度重视计量工作,将本实施方案的任务与国民经济和社会发展规划有效衔接、同步推进,确保各项任务落细落实。(责任单位:各相关部门)

24.加大政策支持。各区人民政府要对公益性计量技术机构予以支持,加强计量基础设施和计量标准、标准物质、计量数据、产业计量测试等能力建设,强化计量监管和基层、基础能力建设。公益性计量工作所需经费按规定纳入本级预算。加强对计量重大科研项目和计量科技创新支撑平台的支持,促进企事业单位计量科研成果转化和应用。统筹利用现有资金渠道和相关政策重点支持国家级、省级产业计量测试中心、计量科学数据中心、计量技术委员会或联盟等计量领域创新平台或组织。健全激励企业增加计量投入的普惠性政策体系,对企业新购置的计量器具,符合税收相关规定的,允许一次性计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时扣除。(责任单位:各区人民政府,市科技局、市财政局、厦门市税务局)

25.加快计量文化建设。加快计量文化研究及科普基地建设,利用现有的博物馆、科技馆、展览馆等场馆以及计量实验室开展计量科普宣传,推动计量文化及相关成果面向社会开放。推动计量知识进课堂、进企业、进社区,将计量理念融入生产生活,为打造计量品牌和推动计量工作科学发展营造良好氛围。积极弘扬新时代计量精神和传播计量文化,选树计量先进典型,增强新时代计量工作者的荣誉感和使命感。(责任单位:市市场监管局、市教育局、市科技局、市人社局)

26.促进协同发展。加强上下联动和横向协调,加大工作推进力度。积极发挥计量、标准、检验检测、认证认可等国家质量基础设施的协同作用,以精准计量推动标准数据和方法的科学验证,为经济社会高质量发展提供一体化质量基础支撑服务。推动计量与相关领域技术规范共享共用,强化检验检测、认证认可领域计量溯源性要求。充分发挥计量学会、科研院所、高校、产业计量测试联盟等单位和组织的优势和作用,集聚各方资源和力量,共同推动国家现代先进测量体系建设,努力构建统一协调、运行高效、资源共享、多元共治的大计量工作格局。(责任单位:市发改委、市工信局、市市场监管局)

27.狠抓工作落实。市市场监管局会同有关部门加强对本实施方案实施情况的跟踪监测,通过第三方评估等形式开展中期评估、总结评估,总结推广典型经验做法,发现实施中存在的问题并研究解决对策,重要情况及时报告市政府。(责任单位:各区人民政府、市市场监管局)

厦门市人民政府关于同意一处市级文物保护单位更名的批复

厦府〔2022〕365号

市文化和旅游局:

你局《关于提请研究思明区深田路42号市级文物保护单位更名相关事项的请示》(厦文旅〔2022〕344号)文收悉。经研究,现批复如下:

一、同意将市级文物保护单位“兴亚院厦门联络部旧址”更名为“侵华兴亚院厦门联络部旧址”。

二、请根据《中华人民共和国文物保护法》等法律法规要求,会同相关单位做好更名后文物保护单位的保护、管理和利用工作。

厦门市人民政府

2022年11月16日

★市府办文件★

厦门市人民政府办公厅关于印发进一步稳经济稳市场主体若干措施的通知

厦府办规〔2022〕12号

各区人民政府,市直各委、办、局,各开发区管委会,各有关单位:

《关于进一步稳经济稳市场主体若干措施》已经第26次市政府常务会议研究通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。

厦门市人民政府办公厅

2022年11月7日

关于进一步稳经济稳市场主体若干措施

为进一步贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,持续落实落细国家和省扎实稳住经济一揽子政策措施及接续政策,充分释放政策效益,激发市场主体活力,制定以下措施。

一、进一步减轻企业税费负担

(一) 依法减免困难企业房产税和城镇土地使用税。全面落实国家、省相关税收优惠,对2022年同一小微企业、个体工商户已减免至少3个月租金的出租人,可按规定就减租的不动产申请减免1年房产税和城镇土地使用税,具体由厦门市税务局公告实施。(责任单位:市税务局、财政局)

(二)阶段性降低职工基本医疗保险费率。自2023年1月1日至12月31日,用人单位职工基本医疗保险单位缴费率和灵活就业人员职工基本医疗保险缴费率,均在规定费率的基础上降低1%,调整后的参保人员待遇不变。(责任单位:市医保局、财政局、税务局)

二、加大“财政政策+金融工具”支持力度

(三)扩大技术创新基金规模。将技术创新基金规模从100亿元扩大至150亿元。对企业增资扩产、技改项目、研发投入等提供融资支持,企业融资利息费用为2%/年,其余由财政补贴。(责任单位:市财政局、工信局)

(四)扩大增信基金制造业子基金支持对象。将增信基金制造业子基金支持对象从中型制造业企业扩大至中小微型制造业企业,按规定增加中小微型制造业企业信用,帮助其解决“贷不到”和“贷不够”问题。(责任单位:市财政局)

(五)对小微企业首次贷款予以贴息。设立10亿元规模的市小微企业首贷专项贷款,对符合条件的小微企业予以1%贴息,贴息时间不超过1年,单个企业贴息金额不超过10万元。探索以适当形式与增信基金形成联动,发挥政策叠加效应,推动金融机构加大服务小微首贷户的力度。(责任单位:市金融监管局、财政局)

本措施由市财政、工信、医保、金融监管、税务等部门按职责负责解释。

本措施自发布之日起实施,有效期5年,但本措施中已有有效期规定的,从其规定。实施期间,如国家、省另有规定的,按照“就高不重复”原则执行。

厦门市人民政府办公厅关于印发行政许可事项清单的通知

厦府办〔2022〕90号

各区人民政府,市直各委、办、局,各开发区管委会,各有关单位:

为深入贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革优化营商环境的决策部署,按照《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》(国办发〔2022〕2号)《福建省人民政府办公厅关于印发福建省行政许可事项清单(2022年版)的通知》(闽政办〔2022〕55号)要求,经市政府同意,现将《厦门市行政许可事项清单》予以公布。有关事项通知如下:

一、依法编制行政许可事项清单。各区要对照《厦门市行政许可事项清单》,认真梳理认领本区实施的行政许可事项,抓紧编制公布本区行政许可事项清单。市、区各部门权责清单、市场准入负面清单、政务服务事项基本目录、“互联网+监管”事项清单、投资项目审批事项清单、工程建设项目审批事项清单等涉及的行政许可事项,要严格与行政许可事项清单保持一致并做好衔接。

二、严格实施行政许可事项。市、区各部门要严格执行行政许可事项清单,清单之外一律不得违法实施行政许可,坚决防止行政许可“明减暗增”。市、区审改办要加强对行政许可事项清单实施情况的动态评估和监督检查,会同事项主管部门及时纠正变相许可行为。

三、加强事前事中事后全链条全领域监管。各许可部门坚持“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”原则,逐项明确行政许可事项对应的监管部门,明确监管细则,提升监管的精准性和有效性;翔安区实行相对集中行政许可权改革,要按照改革方案明确行政许可事项对应的监管主体及其职责,加强协同配合。依托全省一体化政务服务平台开展“审管联动”,建立省网上办事大厅与省“互联网+监管”系统的数据互联互通,对调整实施的行政许可事项,要健全管理机制,严格审查把关,落实监管责任,提高监管效能,坚决杜绝一放了之、只批不管等问题。

四、及时做好清单动态调整。中央及省级层面设定的行政许可事项作出动态调整的,由市审改办负责牵头衔接,及时做好相应调整。我市地方性法规草案拟新设、取消行政许可事项、子项,变更行政许可主管部门、实施机关,以及改变设定依据等的,起草部门应当充分研究论证,并在起草说明中专门作出说明;司法行政部门在草案审查阶段,应当征求市审改办意见。行政许可正式实施前,有关部门应当提出调整行政许可事项清单的申请,由市审改办提请省审改办,依法依规调整公布省级及以下各级清单,实施机关做好实施前准备。

附件:厦门市行政许可事项清单(略)

厦门市人民政府办公厅

2022年11月8日

厦门市人民政府办公厅关于成立厦门市人民政府行政复议咨询委员会的通知

厦府办〔2022〕94号

各区人民政府,市直各委、办、局,各开发区管委会:

为规范行政复议案件咨询工作,提高办案质量,提升行政复议公信力,根据《中华人民共和国行政复议法》及其实施条例以及中央和省、市行政复议体制改革方案要求,经市政府同意,决定成立厦门市人民政府行政复议咨询委员会(以下简称"市政府行政复议咨询委员会")。

市政府行政复议咨询委员会由市司法局负责组建,主要为办理市政府重大、疑难、复杂行政复议案件以及改进和完善行政复议工作等提供咨询意见。行政复议咨询委员会主任由市司法局分管领导担任,委员由市司法局从政府机关工作人员、专家学者、执业律师中聘任,并可根据实际工作需要适时进行补充或者调整。市政府行政复议咨询委员会相关组织规程和案件审议规则由市司法局另行制定。

《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市人民政府行政复议委员会试点工作实施方案的通知》(厦府办〔2011〕11号)、《厦门市人民政府办公厅关于成立厦门市人民政府行政复议委员会的通知》(厦府办〔2011〕26号)、《厦门市人民政府办公厅转发厦门市人民政府行政复议委员会关于组织规程和案件审议规则的通知》(厦府办〔2011〕31号)自本通知发布之日起予以废止。

厦门市人民政府办公厅

2022年11月30日

(上接第29页)

第三十一条 医疗保障经办机构应根据年度救助资金预算和资金使用需求,定期向市财政部门报送医疗救助资金使用计划。财政部门应对市医疗保障经办机构报送的医疗救助资金使用计划及时审核并拨付;根据医疗救助对象享受政府资助参加城乡居民基本医疗保险的人数和标准,足额安排参加城乡居民基本医疗保险资金,并及时足额拨付至城乡居民基本医疗保险基金专户。

第六章 资金监督和管理

第三十二条 财政和医疗保障部门应加强医疗救助资金管理,做到资金收支基本平衡,略有结余。

第三十三条 医疗保障、财政、审计等部门应加强对医疗救助资金使用情况监督检查。有关单位、组织和个人应如实提供所需资料,配合做好医疗救助工作调查核实和监管。

第三十四条 建立健全医疗救助社会监督机制,及时将医疗救助对象范围、标准、金额等向社会公开,接受社会监督。

第三十五条 违反本办法采取虚报、隐瞒、欺诈等手段骗取医疗救助资金的,由医疗保障部门按国家、省有关规定处理;涉嫌构成犯罪的,依法移送司法机关处理。

第七章 附 则

第三十六条 本办法由市医疗保障局会同相关部门负责解释。

第三十七条 本办法自2023年1月1日起实施,有效期5年。《厦门市人民政府关于印发厦门市医疗救助办法的通知》(厦府〔2018〕67号)同时废止。

★目录索引★

2022年11月市政府文件目录索引

市府文件

厦府规[2022]

12号 厦门市人民政府关于印发《厦门市职工医疗保险实施细则》和《厦门市城乡居民医疗保险实施细则》的通知

13号 厦门市人民政府关于印发加快推进政务服务标准化规划化便利化实施方案的通知

14号 厦门市人民政府关于印发厦门市医疗救助办法的通知

厦府[2022]

356号 厦门市人民政府关于2022XG04-G和2022XG05-G地块国有建设用地使用权出让方案的批复

357号 厦门市人民政府关于H2022G09-G和H2022G10-G地块国有建设用地使用权出让方案的批复

358号 厦门市人民政府关于2022-26安置型商品房地块国有建设用地使用权出让方案的批复

359号 厦门市人民政府关于机场片区大小嶝连接桥使用海域的批复

360号 厦门市人民政府关于2022JP15地块国有建设用地使用权出让方案的批复

361号 (内部文件)

362号 厦门市人民政府关于2022JG06-G等6宗国有建设用地使用权出让方案的批复

363号 厦门市人民政府关于T2022G02-G和H2022G11-G地块国有建设用地使用权出让方案的批复

364号 厦门市人民政府关于印发贯彻落实国务院计量发展规划(2021-2035年)实施方案的通知

365号 厦门市人民政府关于同意一处市级文物保护单位更名的批复

366号 厦门市人民政府关于轨道交通1号线火炬园站地块配套项目(含在建工程)国有建设用地使用权协议出让方案的批复

367号 厦门市人民政府关于厦门人文公园 (城市公益性公墓)建设项目的批复

368号 (上行文)

369号 厦门市人民政府关于06-06编制单元控制性详细规划修改方案的批复

370号 厦门市人民政府关于集美区杏林新源路32号工业地块建设用地使用权供地方式变更的批复

371号 厦门市人民政府关于T2022P07地块等3宗国有建设用地使用权出让方案的批复

372号 厦门市人民政府关于2022P21地块国有建设用地使用权出让方案的批复

373号 厦门市人民政府关于2021HP03地块B子地块西侧部分市政道路地下空间使用权出让方案的批复

374号 厦门市人民政府关于轨道交通2号线体育中心站(地下)国有建设用地用途和供地方式变更的批复

375号 厦门市人民政府关于厦门湾口海域C矿区海砂矿海域使用权拍卖出让方案的批复

376号 (内部文件)

377号 厦门市人民政府关于2022P22地块等3宗国有建设用地使用权出让方案的批复

378号 厦门市人民政府关于厦门海峡交流中心部分土地用途变更的批复

市府办文件

厦府办规[2022]

12号 厦门市人民政府办公厅关于印发进一步稳经济稳市场主体若干措施的通知

厦府办[2022]

88号 厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市突发公共卫生事件应急预案的通知

89号 厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市突发事件紧急医学救援预案的通知

90号 厦门市人民政府办公厅关于印发行政许可事项清单的通知

91号 (内部文件)

92号 (内部文件)

93号 (内部文件)

94号 厦门市人民政府办公厅关于成立厦门市人民政府行政复议咨询委员会的通知